

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIACIÓN:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PRESIDENTE:

SECRETARIA (E):

48

Recinto Concejo Municipal

28 de abril de 2025

4:57 p.m.

9:02 p.m.

CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 28 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señorita Secretaria, buenas tardes, por favor llamar lista para verificar quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE

Le informo señor Presidente que hay catorce (14) Concejales presentes en la sesión.

Durante la sesión se hizo presente el Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quorum y siendo las 4:57 p.m. de hoy 28 de abril de 2025 doy por instalada la sesión plenaria convocada para el día de hoy.

Por favor leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quorum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Aprobación de Actas:

- Acta No. 33 del 04 de abril de 2025
- Acta No. 34 del 05 de abril de 2025

4. Control Político Proposición No. 08 de 2025 - Secretaría de Salud

Funcionarias Citadas:

- Doctora Luz Stella Diaz Jaller, Secretaria de Salud
- Doctora Mónica Alexandra Naranjo, Jefe Oficina de Contratación

5. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: ***"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***.

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Funcionarios citados:

- Doctora Luz Aurora Espinosa Tovar, Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Doctora Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación
- Doctor Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda

Esta leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales se pone en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay quince (15) votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día, siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado a lista y verificación de quorum, punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día, punto que ya fue aprobado.
3. Aprobación de Actas:

• Acta No. 33 del 04 de abril de 2025

• Acta No. 34 del 05 de abril de 2025

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales se pone en consideración al Acta No. 33 del 04 de abril de 2025; anuncio que se va cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación o negación del Acta No. 33 del 4 de abril de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay trece (13) votos por la aprobación del del Acta No. 33 del 4 de abril de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el Acta No. 33 del 4 de abril de 2025. Honorables Concejales se pone en consideración al Acta No. 34 del 05 de abril de 2025; anuncio que se va cerrar; se cierra la discusión. Tomamos votación o negación del Acta No. 34 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay trece (13) votos por la aprobación del del Acta No. 34 del 5 de abril de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el Acta No. 34 del 5 de abril de 2025. Siguiendo punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Control Político Proposición No. 08 de 2025 - Secretaría de Salud

Funcionarias Citadas:

- **Doctora Luz Stella Diaz Jaller, Secretaria de Salud**
- **Doctora Mónica Alexandra Naranjo, Jefe Oficina de Contratación**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para todos los presentes que nos acompañan en este punto en el orden del día que consiste en que la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Luz Estela Díaz, nos acompañen para dar desarrollo a un cuestionario que mediante Proposición No. 8 de 2025 fue enviado a la Administración respuestas que ya fueron allegadas por parte de la doctora Luz Estela y la Secretaría para que tuviéramos conocimiento todos los Honorables Concejales de las más de 50 preguntas que en su momento se enviaron en este cuestionario.

Entonces, darle la bienvenida a Doctora Luz Estela junto con sus directores y funcionarios para que de acuerdo a nuestro reglamento interno podamos dar desarrollo a este debate el cual consistirá en lo siguiente, daré el uso de la palabra a los Concejales para que de acuerdo a esas respuestas si tienen inquietudes puntuales puedan hacer sus manifestaciones acá en la plenaria, después de los Honorables Concejales daremos el uso de la palabra a la Administración para que haga su respectiva intervención.

Honorables Concejales están en el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica tiene el uso de la palabra.



HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente por darme el uso de la palabra, con un saludo a todos los presentes. Bueno, primero darle las gracias a la doctora Luz Estela porque nos ha enviado unas respuestas frente a las 50 preguntas de más de 400 hojas que me volvieron a colocar a estudiar mucho en los temas de salud, pero sí quiero hacer varias contra preguntas porque lo que hemos buscado desde el Concejo Municipal, precisamente es evaluar realmente las metas del plan de desarrollo frente a los recursos que se invierten y tener unas respuestas claras y tener claro todo el contexto de lo que sucede en la Secretaría que es una Secretaria muy importante en el municipio, que cuenta con una gran cantidad de profesionales de altas calidades profesionales, desde la misma Secretaria pero que en las respuestas que llegaron no apunta a lo que nosotros como Concejales hemos querido evidenciar en las diferentes Secretarías no solo las de salud sino como lo hicimos con las de movibilidades poder encontrar realmente que los recursos que se invierten en los diferentes programas cómo se está impactando realmente la población del municipio y poder nosotros como Concejales evidenciar.

yo tengo varias preguntas de las cuales muchas se las entregaré posterior a la doctora para que nos la responda de manera escrita pero por ejemplo lo que yo no evidencio y que quisiera saber es... bueno, doctora eh Luz Estela nosotros hemos cambiado a través de una decisión del Presidente del Concejo es que no hacen presentación sino contra lo que nosotros evidenciamos de las más de 400 hojas que nos envió contrapreguntamos frente a lo que queremos saber realmente de lo que usted nos respondió. Entonces, por ejemplo, tengo unas preguntas voy a hacer las más importantes, no todas, pero voy a radicarles para que nos puedan responder. porque me salieron bastantes preguntas, por ejemplo:

- ¿Cuál es el impacto real de las acciones de inspección vigilancia y control en la salud pública del Municipio de Chía durante el 2024 y el primer bimestre del 2025?
- ¿Qué indicadores de salud muestran la mejora o el deterioro de estos de estas acciones?
- ¿Qué comparativo se tiene entre el número de inspecciones hallazgos y medidas correctivas aplicadas en el 2022 versus 2024? ¿hubo un crecimiento o una disminución de incumplimiento sanitarios?
- Ustedes nos dicen que hay 5.511 inspecciones realizadas ¿Qué porcentaje de establecimientos cumplían la normatividad en la visita y cuáles después de las medidas correctivas?
- ¿Cómo evidencia la Secretaría de Salud las mejoras?
- Respecto de lo que ustedes nos dicen que el 20% de las muestras de alimentos que no cumplieron con los parámetros normativos ¿Qué impacto se evidenció en términos de reducción de riesgos sanitarios posteriores? ¿tenemos algún registro de reincidencias?
- ¿Qué análisis se han realizado sobre la efectividad de las 89 medidas sanitarias de seguridad aplicadas?
- ¿Cuántos establecimientos reincidieron en incumplimientos tras la imposición?
- En el caso de que las tomas de muestra de agua potable realizadas por el municipio de Chía son una obligación establecida en la normatividad sanitaria

Página 5 de 63

y deben reportarse al área de salud pública del Departamento de Cundinamarca ¿cuáles de las tomas reportadas no corresponden a este cumplimiento obligatorio? Y adicionalmente ¿existe un comparativo de la calidad de agua potable entre los años 2023 y 2024 que permita concluir si hubo mejoras o deterioro en la seguridad del agua de consumo de la población?

- ¿Qué cambios evidenció la Secretaría frente al comportamiento de la población o de los establecimientos comerciales a partir de las 14 jornadas de capacitación realizadas?
- ¿Qué indicadores tiene para mostrarnos la Secretaría de Salud frente a enfermedades transmitidas por alimentos?
- Muéstranos la disminución atribuida a medidas de control y educación implementadas; esto es para saber si lo que está generando digamos la inversión de recursos frente a enfermedades que se transmiten por alimentos nos ha funcionado o nos ha disminuido ¿ha mejorado o no?
- ¿Cuál ha sido la disminución o el aumento del número de PQRS sanitarias de saneamiento ambiental entre 2023 y 2024?
- De los 2.884 kg de carne incautados ¿Cómo se evidenció el impacto en estos operativos en la reducción de enfermedades de origen alimentario o intoxicaciones en el municipio?
- ¿Qué seguimiento se hizo a los establecimientos sancionados o intervenidos para asegurar la sostenibilidad de las medidas correctivas?
- ¿Tenemos evidencia de lecciones aprendidas que se deriven de las estrategias implementadas en el 2024 y cuáles serán corregidas o fortalecidas por el año 2025?
- En el tema de vacunación rábica ¿Qué impacto comprobado se tiene en términos de reducción de accidentes rábicos reportados comparativamente entre 2023 y 2024? Más allá de haber cumplido con la cobertura.
- Respecto al seguimiento de 573 animales agresores en el 2024 y los 130 de 2025 se evidenció un aumento o disminución frente a anteriores y ¿Qué efecto concreto han tenido las capacitaciones y las intervenciones en este indicador?
- Frente a una cobertura reportada de vacunación antirrábica superior al 93% ¿Existe un análisis que demuestre disminución en el riesgo de exposición a rabia en la comunidad?
- En el abordaje de la toxoplasmosis en mujeres gestantes ¿Cuántos casos positivos se reportaron en 2023 y 2024? y ¿Qué cambió en su incidencia para poder atribuir a las capacitaciones brindadas?
- En relación al plan de intervenciones colectivas ¿Qué resultados cuantitativos muestra el modelo preventivo predictivo que ha mejorado los indicadores de promoción en salud y prevención de la enfermedad del municipio?
- Respecto a la implementación de los ocho territorios de salud ¿Existe evidencia cuantificable que demuestre una disminución de riesgos en salud individual o familiar en comparación con los años anteriores a la creación de estos territorios?

- Se menciona en las respuestas que se abordaron 21.888 personas con servicios de promoción y prevención ¿Cuál fue el impacto concreto de estas intervenciones en los indicadores de morbilidad y prevención de la enfermedad frente a 2023? ¿Hay comparativos que ustedes puedan demostrar que existe la mejora?
- En cuanto a la estrategia de salud sexual y reproductiva ¿Cuántos casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía se presentaron en 2023 y cuántos en 2024? ¿Qué porcentaje de disminución se alcanzó y cómo se puede atribuir directamente a las acciones adelantadas?
- En las jornadas de maternidad saludable y otras campañas ¿Qué indicadores específicos se han utilizado para medir la mejora de la salud de las 31 gestantes atendidas? ¿cómo se comparan los indicadores de los años anteriores para evaluar el éxito de las campañas?
- En relación con la estrategia de vacunación ¿Cómo la vacunación extramural casa a casa? ¿Qué datos comparativos existen sobre el impacto de estas estrategias en las coberturas 2023 frente a 2024? ¿puede demostrarse mejoras significativas en la tasa de inmunización especialmente en zonas rurales y poblacionales de difícil acceso? y ¿cómo ha impactado los cambios de horarios en los temas de mejoras en temas de vacunación?

Frente a los centros Charlemos:

- Se menciona que han brindado orientaciones a 411 personas ¿Cuántos de estos casos han sido derivados de atención derivados a atención especializada?
- ¿Cómo se mide el impacto de estas orientaciones en la reducción de trastornos emocionales y disfuncionales familiares?
- ¿Cuántos son los resultados tangibles de las acciones en la disminución de problemas de salud mental a nivel municipal?

En cuanto a la problemática de suicidios y los intentos de suicidio:

- ¿Cuántos casos de suicidio y de intentos de suicidio se han reportado en el municipio en 2023 y 2024?
- ¿Qué medidas específicas se han tomado para abordar esta problemática?
- ¿Cuáles han sido los resultados de las intervenciones en términos de prevención? ¿existe comparativo con los datos que ustedes recibieron de años anteriores?

Sobre la estrategia Gate Kerpes que menciona esta que está orientada a la formación de actores claves comunitarios:

- ¿Cuántos actores clave han sido capacitados hasta la fecha ¿y cómo se mide la efectividad de su intervención en la prevención de suicidios y trastornos emocionales en la comunidad? ¿Existen datos sobre el impacto de estos actores en la reducción de conductas suicidas?

Con respecto a las zonas de orientación escolar comunitaria SOEC:

- ¿Cómo se asegura que estas zonas estén realmente funcionando y cumpliendo su objetivo de prevención de suicidio y mejora mental en las comunidades ¿qué datos tienen al respecto?
- sobre la línea de tele orientación en salud mental establecida para las festividades de año de Navidad y Año Nuevo ¿Cuántas personas utilizaron esta línea de atención y cuál fue la naturaleza de los casos atendidos? ¿Existen estadísticas que demuestren que la intervención ayudó a prevenir suicidios o intentos de suicidios?
- En cuanto a la intervención en ámbitos escolar familiar y laboral y comunitario sobre la prevención de sustancias psicoactivas ¿Cuáles fueron los resultados medibles en las intervenciones? ¿Cómo se han observado las mejoras en la en la salud mental de los participantes?
- En general en términos de prevención de suicidios en el municipio ¿Cuáles son los resultados concretos de las estrategias implementadas hasta ahora? ¿Existen datos reales de reducción de suicidios o intentos de suicidios que permitan concluir que las acciones que el municipio está realizando han sido efectivas para reducir esta gran problemática?

Frente a la ruta integral de atención RÍA se menciona en las respuestas que cuenta con un equipo de profesionales que evalúa la implementación de la ruta integral.

- ¿Cuáles son los criterios específicos utilizados para evaluar la implementación de esta ruta por ciclo vital en los prestadores de salud?
- En cuanto a la relación de la gestión laboral y erradicación de trabajo infantil SIET, se menciona que se aplicaron 200 encuestas a menores trabajadores y sus familias ¿Qué porcentaje de estos encuestados presentó condiciones laborales de riesgo?
- ¿Cuáles son los resultados específicos de las actividades realizadas como las capacitaciones y talleres en cuanto a reducción de trabajo infantil en comunidad?
- ¿Cuántos casos de trabajo infantil han sido erradicado a través de estas acciones ¿y cuál es la evolución de este indicador comparado a años anteriores?
- ¿Tenemos informe detallado de la efectividad de las campañas de sensibilización realizada como los videos y talleres?

Frente a la certificación de discapacidad y el registro de personas con discapacidad:

- En el 2024 se expidieron según el informe que nos pasan, 533 certificaciones de discapacidad ¿Cómo se garantiza que esas certificaciones sean entregadas de manera adecuada a quienes realmente lo necesitan? Ósea ¿Qué auditoría existe sobre que la persona que tenga un certificado de discapacidad sí sea realmente una persona con discapacidad? Y con estos certificados ¿Cuántas personas han recibido beneficios?

Frente a lo que informan de la gestión de servicio al ciudadano:

Se menciona que la oficina de atención al ciudadano ha alcanzado el 99 resultados positivos para los usuarios ¿Cuáles son los criterios utilizados para considerar que un caso ha sido resuelto de manera positiva?



De estos ¿cuántos casos se han resuelto de manera satisfactoria y cuántos han resultado parcialmente resueltos y qué medidas se toman para abordar?

Afiliaciones al sistema de seguridad social en salud:

- ¿Cuántas personas en el municipio de Chía están actualmente afiliadas al sistema general de seguridad social en salud? y ¿Qué porcentaje de la población total del municipio está cubierta por este sistema?
- ¿Qué acciones específicas ha tomado la Secretaría de Salud para garantizar que todas las personas que deberían estar afiliadas al sistema general de seguridad social en salud están realmente afiliadas? sobre todo en contextos vulnerables
- ¿Cuáles son las principales barreras para lograr la cobertura total en el municipio y qué medidas se implementan para superar barreras?

Fortalecimiento de infraestructura hospitalaria pública:

- ¿Cuáles son los planes específicos para fortalecer la infraestructura hospitalaria pública de Chía? y ¿Cuáles son los plazos establecidos para su ejecución?

Y esta pregunta que es muy importante:

- ¿Cuántos casos de desabastecimiento de medicamentos y falta de atención especializada se han reportado debido a deficiencias en infraestructura hospitalaria?

Esta pregunta está muy vinculada a la situación que tiene el país actualmente y a la crisis de salud a nivel nacional, en cuanto a la afectación en las oportunidades de entrega de medicamentos y prestación de servicios se señala que la falta de agendas disponibles, el desabastecimiento de medicamentos y la insuficiencia de profesionales de la salud son los principales problemas reportados por los usuarios.

- ¿Cuáles son las medidas específicas que ha implementado la Secretaría de Salud para resolver estos problemas?
- ¿Cuántos casos tiene reportados la Secretaría de Desabastecimiento de Medicamentos y que hayan sido reportados en el último año? ¿Qué acciones se han tomado para solucionar esta situación?
- Cuando se habla de que hace falta profesionales de la salud la Secretaría ¿Tiene alguna estadística respecto a cuáles son los porcentajes de falta de profesionales en el municipio? y ¿Que acarree la falta de demanda de servicios?

Sobre las jornadas de esterilización y su impacto:

- ¿Cómo se determinaron las veredas y sectores urbanos prioritarios para las jornadas de esterilización? ¿Qué criterios de riesgo fueron aplicados?
- Se reportan 1.093 esterilizaciones realizadas ¿Cuál era la meta establecida para el municipio en el periodo evaluado? y ¿Qué porcentaje de la población canina y felina del municipio representa esta cifra?
- ¿Qué mecanismos de seguimiento se implementaron para garantizar que los animales esterilizados sean efectivamente aquellos en situación de calle o vulnerabilidad?

Frente a las pruebas de leptospirosis:

- ¿Cuál es el resultado de las pruebas de leptospirosis realizada a los animales atendidos? ¿Se detectaron casos positivos? y de ser así ¿Qué medidas específicas de contención o prevención se implementaron para proteger a la población humana y animal?
- ¿Qué otras enfermedades zoonóticas fueron evaluadas o debería haberse considerado en el marco de esta estrategia de atención y prevención?
- Se menciona también en el informe que se realizaron 1.458 esterilizaciones quirúrgicas con la estrategia de desconcentración del equipo quirúrgico, esta cifra ¿Es adicional a las 1.093 esterilizaciones iniciales o se están presentando un dato acumulado? Ósea ¿Las 1.093 hacen parte de esas 1458 o son independientes?
- ¿Qué acciones permanentes o de continuidad se están presentando para mantener el control de la población canina y felina en el municipio una vez se finalizan las jornadas específicas de esterilización?
- ¿Se han establecido alianzas con organizaciones protectoras de animales o profesionales veterinarios para fortalecer esta estrategia?
- ¿Qué mediciones se están realizando para evaluar el impacto real de estas acciones en la disminución de riesgos zoonóticos para la población de Chía?
- ¿La Secretaría tiene datos comparativos que muestren una disminución en reportes de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis a partir de la implementación de esta campaña?
- ¿Qué análisis epidemiológicos se ha realizado para correlacionar el control de establecimientos de alimentos y bebidas con la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos?
- ¿Existen comparativos de brotes o enfermedades de origen alimentario en Chía antes y después de implementar el modelo de inspección basado en riesgo?
- ¿Cuántos funcionarios inspectores cuenta actualmente la Secretaría de Salud para realizar labores de inspección, vigilancia y control?
- ¿Consideran ustedes desde la Secretaría que esta planta de personal es suficiente frente al número de establecimientos registrados y detectados?
- Se menciona en el informe que la meta de 5.000 visitas de inspección en el 2024 se realizó, de esas 5,000 visitas ¿se puede desglosar de esas visitas si correspondieron a primeras inspecciones y a cuántas a seguimiento de incumplimiento de las anteriores?

Sobre el control de vendedores informales:

- Respecto a vendedores informales de alimentos en el municipio ¿Qué acciones específicas de inspección y vigilancia se ejecutaron el 2024 para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias?
- ¿Qué porcentaje ellos tuvieron seguimiento o procesos de sanción por incumplimiento sanitarios?

- ¿Cuántos operativos específicos se realizaron en 2024 para cada categoría mencionada pescado y productos de pesca, expendio de carnes, bebidas alcohólicas, dulces y eventos masivos?

La idea ahí es poder saber cada uno cuánto se ha realizado.

- ¿Qué porcentaje de los establecimientos inspeccionados durante la Semana Santa, el Festival Gastronómico y otros eventos masivos presentaron incumplimientos sanitarios?

Hay un tema que me llamó mucho la atención.

- ¿Qué tan pertinente es la campaña que aparece en el informe sobre Chagas cuando Chía no es un municipio con Chagas, pero obviamente puede haber gente que se desplace a territorio? me llamó la atención.
- ¿Cuál es la justificación técnica y epidemiológica para implementar en Chía una campaña de prevención de enfermedad de Chagas? Considerando que el municipio de Chía por su clima frío no es un área endémica para la presencia del vector “triatomino” o sea el famoso pito.
- ¿Existen registros de casos que sean autóctonos de la enfermedad de Chagas en el municipio de Chía en los últimos 5 años? O ¿Por qué encontraron pertinente hacer esta campaña?
- ¿Cuántas mujeres gestantes tamizadas durante la campaña 2025 tenían antecedentes de residencia o estancia en zonas tropicales endémicas para Chagas?
- ¿Cuál fue el porcentaje de casos positivos detectados frente al total de tamizajes realizados en Chía?

Sobre priorización de recursos, que esto es uno de los temas que nos corresponde como Concejales:

- ¿Qué criterios de priorización utilizó la Secretaría de Salud para destinar recursos a campaña de prevención de Chagas en un municipio no endémico en lugar de reforzar enfermedades prevalentes de climas fríos? ¿Cuál fue el total de esta campaña en 2025 y cómo se justificó presupuestalmente en el plan anual de salud pública]?
- Frente a la coordinación interinstitucional con la Gobernación de Cundinamarca ¿Cuál fue el lineamiento de la Secretaría de Salud de Chía que tuvo por parte de la Gobernación que la obligaran a desarrollar esta campaña? y ¿si hubo alguna flexibilidad para adaptar los lineamientos al perfil epidemiológico?
- Dentro de la estrategia de prevención ¿Qué estrategia se utilizó para asegurar que la campaña no genere una alarma innecesaria en la población dado que el vector no es propio del municipio?
- ¿Está proyectado que la campaña contra Chagas continúe en el año 2026 y bajo qué criterio epidemiológico se decidió su continuidad o su suspensión en el municipio de Chía?
- ¿Qué acciones concretas de restablecimiento de derechos se implementaron después de identificar a los 62 menores trabajadores en el Municipio de Chía?

- ¿Cuántos de esos 62 menores fueron efectivamente retirados de actividades laborales y vinculados a procesos de atención y o programas de protección?
- ¿Para estos casos se coordinó o existió articulación interinstitucional con Secretaría de Salud ICBF y comisarías?
- ¿Qué sanciones o acciones Administrativas se iniciaron contra establecimientos o empleadores que fueron encontrados empleando menores indebidos permisos de trabajo?
- Sobre la prevención y sensibilización de este proceso ¿Qué metodología se utilizó para evaluar el impacto real de las capacitaciones y sensibilizaciones impartidas a estudiantes de grados noveno, décimo y once en las doce (12) instituciones educativas visitadas?
- ¿Se aplicó alguna medición previa y posterior para determinar cambios de conocimiento actitudes o intenciones respecto al trabajo infantil?
- ¿Qué acciones de seguimiento y control planea realizar el CIETI para asegurar que los menores identificados no reincidan en condiciones de trabajo infantil o explotación laboral?

Bueno frente a los temas de cooperar en la construcción y dotación de la infraestructura hospitalaria que es la meta 41:

- El avance de la meta que gestiones ha realizado la Secretaría de Salud para cooperar con la construcción y dotación de un hospital de primer nivel en el municipio ¿Qué recursos ha destinado la Secretaría de Salud para cooperar en la construcción y dotación de un hospital de primer nivel?
- Sobre el avance y cumplimiento de la obra ¿Cómo se justifica que la Secretaría de Salud se declare un avance del 100% de la meta 41 si según el informe aún no ha iniciado el proceso constructivo de la Torre Norte?
- ¿Qué acciones específicas ha tomado la Secretaría para corregir el atraso del 11,24 en la ejecución de la obra reportada a la fecha del informe?
- ¿Cuál es el plan concreto para mejorar el bajo porcentaje de ejecución financiera 14,72 de los contratos de obra e interventoría teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del proyecto?
- ¿Qué mecanismos de supervisión y control tiene prevista la Secretaría de Salud para garantizar el bajo nivel de ejecución no afecte la entrega del proyecto en los tiempos establecidos?
- ¿Cuál es el soporte de no prever desde el inicio del proyecto la necesidad de trasladar el área Administrativa? y ¿Cuáles son los responsables de la omisión que ha generado atrasos?
- ¿Qué casos gastos adicionales ha generado el traslado de áreas Administrativas y asistenciales? y de ¿Qué fuente presupuestal se está financiando?
- Desde la Secretaría de Salud, aunque el que ejecuta es... me imagino la Gobernación, ¿en el contrato del hospital? Pero teniendo en cuenta que hay recursos públicos del municipio ¿Se han identificado dentro de las supervisiones que ha hecho la Secretaría incumplimientos contractuales por parte del Consorcio de Obra o de la Interventoría? y si es afirmativo ¿Qué medidas correctivas se han tomado desde la Secretaría?



- ¿Qué riesgos puede tener la sostenibilidad del proyecto financiero jurídicos? ¿Han sido han sido identificados? Y ¿Qué puedan comprometer la finalización del proyecto de reposición de la infraestructura del Hospital San Antonio?
- ¿Cuáles son los planes de contingencia establecidos para garantizar la prestación continua del servicio de salud?
- Frente al tema del análisis de recursos presupuestales ejecutados hasta la fecha para garantizar ese acceso efectivo a los servicios de salud del municipio ¿Cuáles son las razones técnicas y Administrativas que explican la baja ejecución del 24% de los recursos presupuestales para la ejecución del régimen subsidiado en salud durante la vigencia 2025?
- ¿Qué medidas específicas de gestión se han implementado para acelerar la ejecución de los CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$44.275.306.000) presupuestados? y ¿Qué cronograma de cumplimiento se ha establecido para evitar pérdida de recursos?
- ¿Cómo se está garantizando que los recursos de libre destinación invertidos y los recursos provenientes de cofinanciaciones SGP, ADRES, Coljuegos sean usados exclusivamente para el aseguramiento en salud y no en gastos Administrativos o diferentes al objeto del programa? ¿Existe frente a esto algún informe auditoría interna?
- ¿Qué impacto concreto ha tenido la inversión de casi TREINTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$38.000.000.000) en la calidad oportuna y accesibilidad de los servicios de salud para la población subsidiada?
- ¿Cómo se está verificando en campo que las condiciones de acceso y prestación de servicios de salud mejoren efectivamente como lo enuncia en la estrategia de programas aseguramiento y prestación integral de servicios de salud?

Sobre el informe de gestión y avances en la implementación del sistema integral SISPI para el resguardo Muisca de Fonquetá cerca de piedra:

- Frente a lo que nos respondieron la implementación real del SISPI ¿Puede la Administración municipal demostrar mediante actas de concertación y protocolos específicos que el resguardo indígena participó de manera efectiva en la definición e implementación del sistema integral de salud propia e intercultural CISPI? Más allá de las de la ejecución de jornadas o campañas asistenciales.
- ¿En qué instrumento formal plan territorial, ruta de atención, acuerdos, articulación consta que las acciones 2024 corresponden a una implementación articulada del CISPI? Y no simplemente a la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC.
- ¿Cómo se garantiza que la identificación de riesgos en salud a las 834 personas respecto a la cosmovisión prácticas y modelos propios del resguardo Muisca y no simplemente fue una caracterización epidemiológica convencional?
- ¿Qué indicadores de armonización de saberes y autonomía en salud del SISPI fueron medidos o están siendo monitoreados en las acciones desarrolladas?

- ¿De qué manera se respetó la autonomía del resguardo para decidir sus prioridades en salud dado que la oferta institucional desplegada parece corresponder a programas estándar de la Secretaría de Salud? Vacunación desparasitación medicina general y no necesariamente a un a un plan propio de salud que es también intercultural.
- ¿Cuál es el cronograma específico para la actualización del plan de salud propia 2025-2030? Y ¿Cómo se garantizará que no sea un simple anexo del pico o sea el plan de intervenciones colectivas sino un plan autónomo conforme a los principios del CISPI?
- ¿Qué mecanismos de participación efectiva y decisión autónoma ha dispuesto la Administración para que el Resguardo Muisca priorice sus necesidades defina intervenciones y ejerza control sobre la ejecución del CISPI?
- Frente a la sostenibilidad del programa SISPI ¿Qué recursos humanos técnicos y financieros están previstos para el sostenimiento de un equipo de salud propio y diferencial para el resguardo evitando que las acciones queden reducidas a brigadas aisladas?
- ¿Existe algún componente de fortalecimiento de capacidades locales formación de promotores indígenas en salud propia como parte del CISPI? O ¿Las actuaciones siguen siendo exclusivas de personal externo? En esto sí ¿Qué tantas qué tanto personal del resguardo indígena hace parte de los equipos de salud?
- Sobre la articulación normativa ¿Cómo se están integrando las acciones de salud propias con la normatividad vigente? Decreto 1953 de 2014 decreto 1146 de 2020; que regula los sistemas de salud propios e interculturales para pueblos indígenas en Colombia.

Frente a la pregunta explique cómo se está fortaleciendo el sistema de información en salud en el Municipio durante 2024 detallando cantidad de datos cargados en plataformas oficiales:

- ¿Cómo se asegura que la Secretaría de Salud Municipal la trazabilidad, integridad y auditabilidad de los datos cargados en las plataformas oficiales considerando que no se han invertido recursos en herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de la información en salud pública?
- ¿Qué medidas específicas y documentadas se han implementado para verificar la calidad del dato en origen IPS, EPS, programas comunitarios, antes del cargue a las plataformas nacionales y departamentales?
- ¿Qué protocolos tiene la Secretaría frente a auditoría interna de datos? Si es así solicitaría que los informes sean anexados a este control político.
- ¿Qué plataformas o soluciones de automatización fueron implementadas exactamente?
- ¿Qué módulos se automatizaron por ejemplo alertas, controles de versiones, reportes y cuáles son los niveles de cobertura en los procesos de la Secretaría?

Frente a las plataformas oficiales:



- ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de actualizaciones a tiempo en SITESIGO, SIPI y PPIP durante la vigencia 2024 de acuerdo a los reportes de control interno o auditorías?
- ¿Cuántos proyectos de salud pública gestionados por la Secretaría de Salud de Chía se encuentran reportados a la fecha en el PPIP y cuál es su estado de ejecución, planificación, ejecución y cierre?

Sobre la plataforma Mango y Seguridad alimentaria, frente a la caída que tuvo el sistema Mango en agosto de 2024:

- ¿Qué mecanismos de contingencia adoptó la Secretaría Municipal para garantizar la continuidad de la vigilancia alimentaria y nutricional?
- ¿Qué acciones correctivas ha implementado la Secretaría de Salud ante la disminución de calidad y oportunidad de la información de vigilancia alimentaria tras la suspensión de la plataforma Mango?
- ¿Qué mecanismos de validación y control de calidad de datos existen en la plataforma SIPS para evitar la emisión de certificados sanitarios a establecimientos no conformes?
- Dado el volumen, 5.072 visitas realizadas en SICRIESAN en 2024, existen indicadores de oportunidad y cierre de hallazgos derivado de las inspecciones, ¿Cuál es el cumplimiento?
- ¿Cuál es el porcentaje de rechazo de novedades radicadas ante el adres en 2024 y ¿cuáles fueron las causas más comunes de rechazo?

Sobre la identificación de riesgos en salud pública:

- ¿Cuál es la metodología específica que se utiliza para identificar los riesgos relacionados con enfermedades transmisibles por vectores, mosquitos, roedores y qué frecuencia se tiene para actualización de datos sobre la proliferación de vectores en diferentes zonas del Municipio?
- ¿Cuál es el proceso técnico para determinar zonas críticas en la prevención de enfermedades como la rabia, toxoplasmosis y leptospirosis y cómo se asegura que todas las áreas de alto riesgo sean priorizadas en la implementación de la estrategia?

Frente a la estrategia nutricional:

- ¿Qué indicadores específicos se utilizan para medir el impacto de los programas de alimentación escolar en prevención de desnutrición y obesidad y cómo se mide el alcance real de estas estrategias en diferentes grupos poblacionales?

En cuanto a la vigilancia nutricional:

- ¿Cómo se garantiza que los programas de educación nutricional se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad, considerando las diferencias de cultura alimentaria y acceso a recursos?
- ¿Qué planes específicos de respuesta a esto frente a emergencias de alto impacto?

- ¿Qué planes específicos de respuesta rápida tiene el Municipio para enfrentar emergencias de alto impacto como una pandemia, un desastre natural en términos de gestión de recursos humanos, material y logístico?
- En caso de una emergencia sanitaria de gran magnitud ¿Cómo se coordina la respuesta de la Secretaría de Salud y organizaciones comunitarias?
- ¿Existen planificaciones específicas para la atención sanitaria a poblaciones vulnerables como personas sin hogar, indígenas o grupo de población flotante?

Hay una pregunta que tengo acá y es:

- ¿Qué pasó con la ejecución de la estrategia de ciudades entornos y ruralidades saludables y sostenibles CERSS del Ministerio?
- ¿Cuál es el proceso específico para la renovación anual del compromiso político por parte del Alcalde y qué mecanismos de seguimiento existen para asegurar que este compromiso se traduzca en acciones concretas durante todo el año?

En términos de fortalecimiento del liderazgo local:

- ¿Cuáles son las medidas específicas que se han implementado para garantizar el liderazgo en salud y alimentación saludable claramente definido y no se logre una gestión efectiva a nivel territorial?

En el informe que nos presentaron aparece prácticamente un copy page de cómo se hace el Plan Territorial de Salud, pero realmente la respuesta que se solicitaba era cómo estaba articulado con el Plan de Desarrollo, digamos que la respuesta no aborda de manera directa el Plan Territorial de Salud, si está efectivamente articulado con el Plan de Desarrollo aunque aquí nosotros lo aprobamos, pero lo que nosotros queríamos o lo que las preguntas que se hacía desde el Concejo era poder evidenciar punto a punto del Plan Territorial cómo está cumpliendo las metas y eso cómo está impactando al Municipio, entonces no aparece en el informe detalles exactos del avance, ¿cómo está avanzando el Plan Territorial?

Nosotros acá ya estamos acostumbrados a que los Secretarios nos traigan estadísticas, nos digan cómo se está impactando el territorio y digamos que el Plan Territorial de Salud es el Plan de Desarrollo que es hacia dónde va la salud en el Municipio, y realmente la respuesta explica, nos enseña claramente la normativa de cómo construir un Plan Territorial de Salud, pero no nos muestra a nosotros como Concejales cómo se está desarrollando las metas, cómo están impactando y digamos el Plan Territorial de Salud es esa guía de ruta que tiene el Municipio frente a cómo se está desarrollando, y la idea era que nos hubieran respondido eso, no como se hace el Plan Territorial de Salud sino cómo está impactando las metas del Plan de Desarrollo, esa respuesta realmente aquí no la hemos evidenciado y realmente si es lo que queremos ver las estadísticas frente a cómo ha evolucionado el año 2024 y está evolucionando hacia el 2025, para que realmente estos recursos que el Concejo Municipal de Chía ha aprobado a través de la armonización del Plan de Desarrollo y que además dentro de su responsabilidad en las modificaciones y adiciones presupuestales se han realizado.

Y la otra pendiente que creo que la preguntaron varios Concejales también, es dejar claro la salida del convenio de gestión de emergencias médicas y coordinación intermunicipal que corresponde a un convenio SSCDBI-5802019 con la Gobernación de Cundinamarca y qué otras alternativas como ajustes, modificaciones del dentro del marco del convenio se sugirieron antes de optar por la salida:

- ¿Cómo afecta la desvinculación de Chía al convenio en la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia médica?
- ¿De qué manera se garantizará la continuidad y la eficacia de los servicios de emergencias médicas en el Municipio de Chía tras la terminación del convenio?
- ¿Qué impacto puede tener la desvinculación de Chía en la coordinación de emergencias médicas a nivel departamental y en la efectividad del SEM en Cundinamarca?
- ¿La decisión de salir del convenio influye en la distribución de recursos o en la gestión del presupuesto asignado?
- ¿Qué recursos financieros, técnicos y humanos estaban destinados al sistema de emergencias médicas como parte del convenio SSCDBI-5802019 y en qué meta del Plan de Desarrollo se encuentran comprometidos?
- ¿Cómo se ha ejecutado o si no se ha ejecutado, cómo se ha ejercido de alguna manera el cumplimiento de contratación de personal, recursos y metas comprometidas, el monitoreo y seguimiento?

Estas son en general, aunque son más, pero son en general las preguntas y otro tema que es importante, es saber también en todo lo que genera en la Secretaría de Salud tiene un área de riesgos en todas las enfermedades que obviamente reportan a la Secretaría de Salud y donde el área de epidemiología tiene gran importancia, y parte de las preguntas lo que buscan es eso, que nos digan lo que se está ejecutando, las actividades son estas y lo que hemos logrado en impacto a la salud de los ciudadanos de Chía, es esta.

En el informe está explicado toda la teoría, pero realmente en esa gran cantidad de hojas no se evidencia realmente que nosotros los Concejales podamos evidenciar comparaciones claras para evaluar que los recursos que están siendo invertidos realmente están impactando la salud de los ciudadanos, que seguramente lo tienen hecho, pero no lo expresaron seguramente traen la presentación para observarla.

Y también quiero saber el Municipio desde la Secretaría de Salud que análisis tiene frente al impacto de la crisis en salud a nivel nacional y qué se ha encontrado en el Municipio o qué acciones hay para tratar de solucionar las dificultades que puedan tener los usuarios, además si existen unas estadísticas o unos elementos en datos que puedan permitir y evaluar ¿cuál es la situación de crisis si existe o no en el sistema de salud para los usuarios del Municipio de Chía?

Gracias Presidente por la intervención, fue un poquito larga, pero es que también las respuestas fueron largas, entonces fue bastante análisis para poder determinar las preguntas que también realicé para la intervención del día de hoy.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Muy de acuerdo con lo que usted dice, también aprovechar un saludo especial para la Administración Municipal en cabeza de la doctora Luz Stella y las personas que nos acompañan a través de las barras, de los diferentes medios, agradecerles por la información lógicamente muy nutrida.

Concejales continúan con el uso de la palabra, Concejal Felipe Galvis.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Gracias Presidente, con un cordial saludo para la doctora Luz Stella, la doctora Mónica Naranjo, todo el equipo de la Secretaría de Salud, las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, las que están presentes hoy en el recinto, Honorables Concejales, Mesa Directiva.

Presidente, tengo unas preguntas que forma respetuosa al igual la Administración hay algunas que se repiten en lo relacionado con lo que acaba de manifestar la Concejal Angélica, pero estas preguntas que yo tengo creo que si guardan directa relación con el cuestionario que fue aprobado por esta Plenaria hace unos días, y el cual le fue allegado a la doctora Luz Stella.

Entonces me voy a permitir leerlas, quiero que haga énfasis en estas preguntas doctora porque ya las demás respuestas de las preguntas que se le allegaron a usted ya tengo conocimiento, pero estas quiero que haga cierto énfasis.

En cuanto a la pregunta No. 1 donde esta Corporación le requiere un informe detallado sobre el estado del avance de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 en materia de salud, especificando los indicadores de cumplimiento, ejecución presupuestal y acciones implementadas para garantizar la cobertura accesibilidad y calidad en la prestación de los servicios a la fecha, me gustaría preguntarle:

- ¿Cuántas medidas sanitarias de seguridad se interpusieron en establecimientos de comercio abiertos al público, si existe alguna sanción?,
- ¿Cuántos certificados de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad se expidieron en el año 2024?

Porque pienso que es importante que la comunidad sepa que este proceso de caracterización, además de tener una base de datos también les sirve a todas estas personas obtener beneficios sociales y económicos, espero que sumercé en su respuesta nos amplíe que beneficios sociales y económicos tienen estas personas con discapacidad que se encuentran caracterizadas hoy en el Municipio.

Preguntar también ¿cuántas tomas de muestra de agua se han realizado en los distintos puntos de la red de distribución de agua potable en la vigencia 2024 y lo que lleva la 2025? Ya que tengo que conocimiento que desde su Dirección se han realizado estas acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, preguntar si ¿estas tomas dónde fueron realizadas? Y conocer el análisis de estos resultados si podría especificar en eso doctora, ya que la comunidad hace denuncias sobre el estado del agua en el Municipio, se preguntan que, si el agua que nos llega cumple con los estándares de calidad, con los rangos establecidos en la Resolución 2115 de 2007, para asegurar su potabilidad, y además si se ha realizado denuncias sobre este tema, las entidades correspondientes.



En temas de salud mental quiero solicitar que haga énfasis en la estrategia que implementó su Secretaría de los centros Charlemos, esa pregunta ya se había referido la Honorable Concejal Angélica cuyo objetivo es proporcionar atención primaria en salud mental, la pregunta va más que todo guiada a ¿cuántos puntos de atención han instaurado para llevar a cabo este servicio? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Qué servicios se ofrecen? ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas directamente de esta estrategia? También saber ¿qué campañas de promulgación y divulgación de estos servicios ha realizado la Administración para llegar a toda la población del Municipio de Chía?

En cuanto al aseguramiento y la prestación del servicio de salud quisiera que se enfatizara en el acompañamiento que se le ha brindado a los ciudadanos del Municipio de Chía enfocado a la gestión de casos relacionados con el desabastecimiento de medicamentos, la falta de oportunidad en la atención o en la deficiencia de la atención en las IPS, si nos puede indicar la cantidad de PQRS gestionadas desde su área, desde su Dirección en relación a lo que acabo de mencionar, es decir, el desabastecimiento de medicamentos, preguntar si: ¿se ha realizado alguna auditoría a los gestores de medicamentos que hacen presencia acá en nuestro Municipio?

Y ¿de parte de la Secretaría se ha verificado la entrega oportuna de medicamentos y pendientes dentro de los tiempos normativos en cada uno de los dispensarios contratados por entidades Administrativas de planes de beneficios de salud presentes en el Municipio como Audifarma, Cruz Verde, Evedisa Cafam, Colsubsidio y Surtidrogas?

De igual manera preguntar ¿qué seguimiento se ha realizado a la prestación de servicios de urgencias en las IPS que hacen presencia del Municipio de Chía? Teniendo en cuenta que en Chía contamos con el Hospital San Antonio, con la clínica Chía, con la clínica Universidad de La Sabana, y con la clínica Marley.

Y por último en cuanto al control de la población de caninos y felinos del Municipio ¿cuántas cirugías o cuántas esterilizaciones a caninos y felinos se han realizado durante la vigencia 2024?

Estas son mis preguntas por el momento Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, tiene el uso de la palabra el Concejal Pablo Castro.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, primero un saludo de buenas tardes para la Mesa Directiva, para los compañeros Concejales, para la doctora Luz Stella Díaz Secretaria, el doctor Willy Reyes, la doctora Laura, la doctora Mónica Naranjo.

Yo quiero empezar doctora Luz Stella por reconocerle su buena disposición en el cargo, denota su voluntad y capacidad de servicio cada vez que la comunidad la ha Necesitado, sé que ha estado ahí incluso fuera de sus horarios de oficina y eso hay que reconocerlo, yo sé que es lo esperable como dice no es aplaudir al cajero porque me entrega mi plata, no, pero es que no solamente es cuando hablamos de la

eficacia y la eficiencia, no, solamente una de las dos es cumplirlo y además hacerlo bien y creo que usted lo está haciendo bien y cuando usted en la rendición de cuentas va mira uno de los porcentajes de ejecución de las metas producto a cargo de su Secretaría, creo que resulta ser la Secretaría mejor librada casi que al 100%, entonces debo hacer ese reconocimiento al iniciar mi intervención.

Y solamente tengo una consideración y una inquietud y esto es aprovechando que está aquí la doctora Mónica Naranjo el año pasado cuando hicimos el control político en torno del empréstito hubo algo que resultó muy evidenciador, pero las respuestas que dio usted doctora Mónica y era que la Administración Municipal no podía invertir, ni aún por vía de financiación recursos y menos por vía de endeudamiento en un hospital, que además no es de carácter local sino es departamental y usted en su momento leyó la norma todos los temas puntuales en los cuales sí puede invertir el Municipio y en cuáles no, y fue muy claro y además se lo agradecemos en que la Administración no podía invertir ahí, son VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$25.000.000.000) que ya fueron entregados, yo quisiera saber desde aquel entonces doctora Mónica ¿qué medidas de orden legal quiero decir tanto jurisdiccionales, como ante los entes de control se han adelantado en torno de ello por parte de la Administración Municipal? En la medida que ya fue evidenciado en un control político y fue además muy clara su explicación ese día.

Básicamente eso era en lo que quería participar.

Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Concejal, Honorables Concejales continúan con el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Marcela Pedraza.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, un saludo para mis compañeros Concejales, a los representantes de la Administración que nos acompañan el día de hoy, las personas que se encuentran presencialmente en el recinto y las que nos siguen por redes sociales.

Doctora Luz Stella yo tengo unas preguntas después de leer las respuestas que nos enviaron, quisiera iniciar por estas:

Primero, ¿cuáles son los principales riesgos que podrían retrasar el cumplimiento total de las metas de salud para el 2027 según lo que se ha proyectado y lo que se ha analizado en este año y medio?

Segundo, ¿qué porcentaje de los establecimientos con concepto sanitario desfavorable lograron corregir sus deficiencias tras la visita y del seguimiento?

Tercero, ¿qué estrategias nuevas tienen previstas para disminuir la resistencia de comerciantes al cumplimiento de normativas sanitarias?

Siguiente, ¿cómo está conformado el equipo interdisciplinario SISPI?

Siguiente ¿qué acciones y recursos se han ejecutado para el desarrollo de SISPI?

Siguiente, frente al convenio 580 vi que nos relacionaron una respuesta, quisiera saber si ¿está ejecutándose actualmente y cuál es el presupuesto que se destinó para dicho convenio? Teniendo en cuenta que es un convenio interadministrativo donde están varios municipios.

Quisiera saber cómo se está incluyendo a las zonas rurales dispersas que puedan quedar fuera dentro del muestreo que se ha concentrado en el agua, de lo que ya han hablado varios compañeros

Quisiera saber también ¿qué estrategias se tienen para aumentar la cobertura de vacunación en zonas rurales donde puede haber animales de difícil acceso?

También si ¿se ha detectado algún brote de enfermedades zoonóticas no controladas a pesar de las campañas que se han realizado en el Municipio en esta vigencia?

También quisiera saber ¿cómo se está midiendo el impacto real de las brigadas y las jornadas de salud sobre los indicadores de morbilidad y mortalidad en el Municipio?

¿Qué dificultades se encontraron en la implementación de la estrategia una sola salud y cómo planean superarlas?

Quisiera saber ¿qué medidas específicas se han tomado ante el desabastecimiento de medicamentos que tenemos a nivel nacional? Igual sabemos que es una problemática nacional y no solo municipal.

También quisiera saber ¿qué seguimiento se está realizando a las personas orientadas en los centros Charlemos para asegurar que continúan en el tratamiento si lo requieren?

También, si ¿se han identificado cambios en las tasas de intento de suicidio o consumo de sustancias luego de implementar las estrategias que nos relacionaran en las respuestas del cuestionario?

Quisiera también que nos informaran sobre ¿cuál ha sido el impacto medido de las estrategias nutricionales en poblaciones vulnerables caracterizadas según la respuesta que nos allegaron?

¿Qué barreras se han identificado para mejorar los hábitos alimenticios en las comunidades intervenidas?

Y en cuanto al avance que se ha reportado en la construcción del hospital, quisiera saber si existen acciones concretas que puedan tomarse según la competencia que tiene el Municipio frente a la infraestructura y la necesidad que tiene el Municipio.

Gracias Presidente, estas serían mis preguntas.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Página 21 de 63

A usted Honorable Concejal, Concejales continúan con el uso de la palabra.

Bueno doctora dentro de mi intervención, yo solo tengo una inquietud más allá de una inquietud, me gustaría saber cuál ha sido la articulación de la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Medio Ambiente por una de las estrategias que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo, como ustedes lo saben yo he venido de alguna manera solicitando que se cumpla la ley 2254 del año 2020 que hace referencia al Centro de Bienestar Animal y que tiene que quedar en cabeza de alguna de estas tres (3) dependencias, también hice la solicitud Desarrollo Económico, a Salud no la hice, pero sé que no está dentro del cuestionario sería bueno si de pronto nos puede contar, si no será en otro momento, pero si sería bueno que quedara acá sobre la Plenaria, que nos contara cuál es la articulación que se ha venido teniendo hasta el momento sobre este importante centro, que como usted bien sabe vuelvo y lo reitero cobija tres (3) dependencias: Medio Ambiente con la fauna Silvestre, Desarrollo Económico con los animales de producción o especies mayores y la Secretaría de Salud en este caso en cabeza suya con especies menores o mascotas.

De mi parte no me queda más también sino agradecerle por toda la disposición que ha tenido para con la comunidad, creo que siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar los dos usted y al igual que su equipo de trabajo le brindan ese acompañamiento que la comunidad en realidad necesita y creo que eso también hay que resaltarlo aquí en la Corporación.

Muchas gracias, Concejales continúan con el uso de la palabra.

Quiero preguntarle a los Concejales si hay alguno quiere intervenir o le damos la palabra a la Administración.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Concejal Laura García.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, buenas tardes a toda la Plenaria, especialmente a la doctora Luz Stella Díaz, quiero enfocar mi intervención en cuatro puntos.

El primero es sobre la salud mental ya he tenido la oportunidad de poder dialogar sobre esta problemática con la doctora Luz Stella mencionando y creo que usted lo va a decir en su intervención que esta es una problemática global, que en este momento está siendo como una nueva pandemia y el Municipio ha dado grandes avances, pero yo quiero mencionar algunas cosas que me gustaría poder trabajar y también preguntarle si se ha considerado desde la Secretaría de Salud.

Primero es que conozco el programa Charlemos, pero me gustaría saber si hay una articulación entre el centro Charlemos y las EPS, porque es que a veces el centro Charlemos cumple con esa introducción, con ese primer acercamiento al paciente, pero necesitamos un tratamiento mucho más profundo, más completo y la EPS como usted lo mencionaba en las respuestas según la auditoría demoran esos



tiempos, entonces ¿cómo se hace una articulación efectiva para que estos pacientes no tengan un riesgo? Porque sabemos que la salud mental pende de un hilo, entonces tenemos que llegar cada vez más lejos y lograr que todos los actores que giran alrededor de él estén alineados y funcionen con la misma celeridad que la Secretaría de Salud.

También si se ha pensado una estrategia para llevar el centro Charlemos a las diferentes veredas, para no solo enfocarlo en la casa de la mujer o me pareció muy oportuno lo que sucedió en las épocas altas que fue tener ese servicio vía telefónica me parece que podríamos manejar esa estrategia para que continúe en el tiempo, ya usted nos mencionará si es o no es oportuno y posible, pero me gustaría poder ver que ese manejo que se le está dando a la salud mental pueda llegar mucho más lejos y sobre todo a las zonas rurales.

También mencionaban respecto al manejo y las inspecciones que usted ha hecho que el 40% de esas medidas sanitarias fueron aplicadas por plagas, a mí me gustaría saber qué estrategias de prevención se está manejando, teniendo en cuenta que si bien hacemos una inspección es importante poder prever para que vayan disminuyendo este número de medidas aplicadas por el manejo de las plagas.

También tengo que felicitar la instalación de los contenedores de las “heces” de los caninos esta era una queja constante en tiempos de campaña de todas las personas especialmente las personas que habitan en los conjuntos residenciales, ustedes lograron innovar y yo creo que somos uno de los municipios que maneja un programa tan eficiente, entiendo que es un programa piloto, pero me gustaría conocer ¿cuál es la estrategia o las acciones que tienen contempladas para poder ampliar este programa? Porque no tengo dudas que va a ser un éxito, porque es una necesidad que el Municipio tiene.

Y también quiero conocer si de pronto dentro de la presentación que ustedes manejan tienen una comparación de datos sobre las enfermedades, que tiene que hacerle seguimiento la Secretaría, con el fin de conocer los avances que ustedes han llevado en esta vigencia.

Por el momento sería esto y de igual manera y en línea con el Concejal Pablo felicitarla doctora Luz Stella porque usted es una persona con don de servicio y eso hay que resaltarlo en este tipo de escenarios.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Concejal Laura, Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente, un saludo cordial a la Plenaria del Concejo Municipal, a las personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, por supuesto un cordial saludo a la Secretaría de Salud, y demás funcionarios de la Administración Central.

Presidente, yo creo que en el mismo sentido que los demás compañeros es evidente, que vuelvo a ser reiterativo con esta Secretaría como lo he hecho con las demás y es revisar el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal diciendo si no el mejor sector que tiene la Administración Municipal, vendría siendo el segundo con Obras Públicas porque seguramente han hecho absolutamente casi que todo, una evidencia esas metas, No. 33 donde habla de personas con servicio de certificación de discapacidad se cumplió, pero lo más importante que quiero rescatar en lo que nos muestra la ejecución financiera y la ejecución física, es que la planeación que usted realizó fue casi que casi que perfecta, porque entonces una evidencia que en efecto existe un presupuesto apropiado, un presupuesto comprometido y un presupuesto obligado y allí hay que mostrarles a las personas que evidencien que en efecto cuando el apropiado para el año 2024 es casi igual al obligado, eso quiere decir que en efecto se está revisando muy bien el presupuesto que se está ejecutando por parte de la Secretaría de Salud, entonces yo creo que igual que los demás Concejales primero que todo resaltar esa dedicación, seguramente una de las decisiones más atinadas que de pronto tuvo el señor Alcalde poniéndola a usted en esa Secretaría, no obstante si solicitarle que me complemente la meta No. 35, de ella no tengo ninguna información respecto a la ejecución física, ni financiera, la cual hace referencia a implementar una estrategia de gestión de riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas, si entonces, me gustaría conocer ¿cuál fue la ejecución presupuestal? Indudablemente necesario decirlo no solamente en este sector sino en los demás que básicamente cuando evidenciamos las diferentes metas del Plan de Desarrollo también hay que hacer énfasis que algunas que no se ejecutan, es decir, quedan en 0%, pero porque están suspendidas para cumplirse en los demás periodos, entonces que es eso lo que quiero conocer, me asalta mucho la duda de dos preguntas específicas una ¿cuál es el procedimiento establecido porque creo que se la he realizado a Gobierno y es que voy a leer la textual ¿cuál es el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico colombiano y acá tenemos que irnos a la ley 1801 del 2016, frente al decomiso, incautación o disposición de alimentos en situaciones de riesgo para la salud pública y adicionalmente dicho procedimiento es adelantado directamente por la Secretaría de Salud o a través de un contrato celebrado por un tercero? Entiendo que este decomiso y esto que debe realizarse, la pregunta se hace en coordinación en armonía con Secretaría de Gobierno, que de pronto nos pudiese explicar o complementar un poco más.

También me gustaría que hiciera énfasis no recuerdo cuál es la pregunta, pero ahí en el cuestionario usted habla de la prevención de enfermedades “Chagas” que son enfocadas principalmente a las mujeres gestantes, entonces me gustaría que de pronto complementara un poco esa pregunta.

Por último, me gustaría preguntarle doctora Luz Stella frente al Hospital San Antonio, yo sé, entiendo que en efecto el Concejal Pablo Andrés hizo unas solicitudes frente al estado actual jurisdiccional ¿cierto? Instaurado por la Administración Central, pero lo cierto es que al final del día tenemos que tener un estado actual del seguimiento que se le hace a estos dineros ¿cierto? No sé si todavía sigue un supervisor que esté pendiente de lo que viene sucediendo, pero también me gustaría saber si de pronto se ha podido tener alguna Conversación, yo entiendo que esto deberíamos hacerlo los Concejales, no ustedes, pero saber si la Asamblea de Cundinamarca, creo que no ha realizado ningún control político en torno al Hospital San Antonio y no sé si de pronto usted tenga conocimiento, porque he buscado pero no he hecho la solicitud formal para saber si se ha realizado algún control político del Hospital San Antonio en la Asamblea de Cundinamarca, pero en definitiva que nos diga el estado actual de lo que en su competencia tiene que ver con el Hospital San Antonio.

Esas son mis preguntas Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

A usted Honorable Concejal, Concejal Edgar Francisco Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias Presidente por el uso la palabra, las buenas tardes para los compañeros Concejales, para los funcionarios de la Administración hoy en cabeza de la doctora Luz Stella todo su equipo de salud que hoy nos acompañan, personas que hoy nos acompañan en el recinto, personas que nos siguen en redes sociales.

Y doctora Luz Stella también agradecerle a usted por su gran trabajo que está desempeñando en la Secretaría de Salud, su acercamiento a la comunidad que ha sido lo más importante, lo he visto y lo he vivido y he acompañado algunos procesos suyos y es de gran alegría saber que se cuenta con usted, con una persona entregada a la comunidad, con ese gran servicio que usted presta desde su labor de Secretaria, de verdad que es muy importante y es de reconocerles su gran labor, que hace con ellos su entrega, así sea una llamada que hagan el momento preciso, eso es de gran ayuda para ellos y es agradecerle desde este recinto por su gran trabajo, su desempeño como Secretaría de Salud.

También me uno a la pregunta que hace el Concejal Vela el tema de la construcción del hospital, es muy importante para nosotros saber este proceso sumercé sabe que hemos estado un poco pendientes, algunos Concejales estuvimos en una invitación también hecha por usted y compartimos con las personas que están allá trabajando y están interesadas, y quisiera saber también el adelanto la hora todo lo que ha pasado después de que hicimos esa visita, y que nos cuente un poco más de cómo va ese proceso tan tedioso que nos informaron ese día, por qué no se podía avanzar, por qué no iba más rápido la obra, porque los recursos estaban, pero había un tema logístico que no dejaba o no deja de pronto avanzar esta obra ¿qué ha pasado con eso? Quisiera que nos informara un poco más sobre eso, y nuevamente muchísimas gracias por toda su labor.

Gracias señor Presidente por uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Concejales continúan con el uso de la palabra.

Concejales continúan con el uso de la palabra, bueno si no hay más intervenciones por parte de los Concejales, me gustaría en estos momentos darle la palabra primero la bienvenida nuevamente a la Administración, darle la palabra me imagino que a la doctora Luz Stella, a su equipo de trabajo, aprovechar también darle un saludo muy especial a la doctora Mónica Naranjo que nos acompaña, no la había visto, doctora Luz Stella queda usted con el uso de la palabra.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Muy buenas tardes Honorables Concejales, de igual manera quiero dar un saludo muy especial a todo el personal Administrativo de la Honorable Corporación Concejo Municipal de Chía, a la Mesa Directiva y a todos y cada uno de los Concejales que a bien y todos los 15 tuvieron efectuar el cuestionario y esta citación mediante proposición No. 008, a todos los ciudadanos del Municipio de Chía que

hoy nos están viendo o que probablemente luego van a retransmitir esta sesión de control político del día de hoy, un saludo muy especial y sobre todo decirles que precisamente hacer Municipio es estar al servicio de toda la comunidad, somos funcionarios públicos, nos debemos a todos y cada uno de ustedes y esto gracias a Dios durante este año y 4 meses lo ha venido entendiendo un equipo de trabajo, que en este momento ya tiene a su cargo de la Secretaría de Salud 161 personas, entre personal de planta y personal contratista dentro de la Secretaría de Salud.

Cuando nos hablan de ese servicio a la comunidad, si bien es cierto, yo los represento a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud son todos y cada uno de ellos que en la experticia y los roles que he venido implementando dentro de la Secretaría de Salud y que ellos han venido también aportando obviamente se merecen este reconocimiento que el día de hoy le hacen a la Secretaría de Salud y no a una persona.

Este control político cuando lo leíamos todo el equipo, porque también concertamos entre todo el equipo y trabajamos mancomunadamente no es una persona la que contesta los cuestionarios que se emiten por parte de este Concejo Municipal, sino que es todo el equipo de acuerdo a la experiencia y al perfil que se tiene, veíamos como el Concejo Municipal se tomó el trabajo realmente de leer nuestro Plan de Desarrollo y preguntarnos exactamente qué habíamos hecho hasta el momento y eso a nosotros nos llenó de mucha satisfacción, porque a veces el sector salud como nosotros no entregamos obras sino que tocamos vidas, salvamos vidas, evitamos enfermedades, pues a veces no es tan tangible la gestión que uno hace, sino al interior de cada una de las familias que nos permiten llegar a sus hogares, por esta razón quiero agradecer al Concejo Municipal y ustedes ciudadanos pueden estar completamente seguros que durante este cuestionario el Honorable Concejo Municipal llevó a cabo un estudio juicioso para realizar un control político a la Secretaría de Salud del Municipio de Chía actualmente del gobierno del Alcalde Leonardo Donoso.

Voy a iniciar cada uno de los temas para que de esta manera podamos ir contextualizando las preguntas que los Honorables Concejales han hecho el día de hoy y que corresponden precisamente al cuestionario emitido a través de la proposición No. 008, por esta razón iniciamos diciéndole a nuestros Honorables Concejales y a todo el Municipio que efectivamente la Secretaría de Salud llegó a una evaluación durante el año 2024, que se evalúa la gestión dependencia por dependencia a un 98% tanto de eficacia como de eficiencia, cuando se evalúa estas gestiones, actividades y acciones a través de nuestra herramienta SITESIGO, que es una herramienta que lo que permite es evaluar la gestión de la Administración Pública en cada uno de esos sectores, nosotros llegamos a un 98%, y esto es bien interesante porque precisamente durante la presentación la metodología que utilizamos Honorable Presidente fue como compilar por temas las 59 preguntas que nos efectuó en el cuestionario el Honorable Concejo y las fuimos compilando por temas para que de esta manera fuera mucho más metódica la presentación de este cuestionario que se adjuntaba a la proposición No. 008.

Con respecto a la infraestructura de nuestro Hospital San Antonio de Chía y si bien es cierto voy a permitirme solicitarle a la doctora Esmith, un permiso para hablar sobre este proyecto porque realmente Honorables Concejales para poder profundizar sobre él, obviamente en el Reglamento Interno se permite hacer, si bien es cierto, no una citación a esta funcionaria por ser funcionaria del departamento de Cundinamarca sí se permite hacer una invitación para que de esta manera ustedes puedan ampliar la información y efectuarle a algunas preguntas que si bien es cierto, hacía también la Concejal Angélica Montañez.

El avance de reposición total de la infraestructura del Hospital hasta el momento de esta proposición iba en una programación del 31.56% y una ejecución del 19.29% presentando un retraso del 12.27% en la obra.

Se realiza la reproducción de un video donde se evidencia el avance de la obra Hospital San Antonio de Chía.

Allá esta es precisamente el momento que ya va un poquito más avanzado del momento que recibimos nosotros el cuestionario por parte de la Honorable Corporación con respecto al avance de la obra del Hospital San Antonio de Chía, nosotros desde la Secretaría de Salud lo que hacemos precisamente es hacerle seguimiento durante la anualidad de cada uno de los periodos del cuatrienio al avance de la obra y sobre todo la asistencia técnica en lo que se refiere al cumplimiento de la normatividad vigente en el sistema obligatorio de garantía de la calidad, la Resolución 3100, guiar que toda la infraestructura posteriormente cuando vaya a recibir la dotación esté preparada específicamente desde lo técnico en cuanto a todos los estándares que en este momento corresponden a todo el estándar de infraestructura, la asistencia por la parte de la Secretaría de Salud, es totalmente técnica y por eso precisamente hablábamos de un cumplimiento del 100%, porque al 100% de los comités de obra que hace el Hospital San Antonio de Chía todos los viernes a las 9 de la mañana del año 2024 y en lo corrido del 2025, he asistido y eso se puede evidenciar en las actas de asistencia que se realizan por parte del equipo de la doctora Esmith, la gerente del Hospital San Antonio de Chía.

Adicionalmente a esto trimestralmente estamos desde la desde la Secretaría de Salud pidiendo informes de ejecución e informes de obra para saber todos los cambios que se vayan dando a la obra correspondiente. Con respecto al arranque de la torre sur y ahorita la torre norte precisamente la anterior gerencia del Hospital San Antonio de Chía no previó que debía trasladar los servicios no solamente asistenciales sino también Administrativos a otro establecimiento precisamente para que las 2 torres fueran dando avance simultáneamente, la Doctora Smith de manera muy juiciosa presentó esta solicitud ante el gobernador de Cundinamarca el doctor Jorge Rey, quien estuvo a disposición de ella, del hospital y de los ciudadanos del municipio de Chía para asignar unos recursos para que se haga realidad.

El 3 de abril de este año se firmó el contrato de arrendamiento en un sector cercano a la vertiente del municipio de Chía donde se trasladarán los servicios asistenciales de nuestro hospital y el área Administrativa va a quedar donde hoy está todo el equipo de ingeniería del consorcio Health precisamente para evitar arrendar y entrar en detrimento con respecto a los recursos públicos, por esta razón a partir del mes de julio se estima que se inicien toda esta prestación de servicios asistenciales en el Hospital San Antonio de Chía en esta sede arrendada, por cuestiones de cumplimiento de pólizas no se puede terminar primero una torre y luego la otra ¿Por qué? Porque hace parte completa de un solo ejercicio contractual.

Esta es la situación que en el momento se vive con el Hospital San Antonio y en las diferentes reuniones de obra que hemos tenido, los contratistas nos aseguran que una vez esté trasladada en el área asistencial y el área Administrativa del Hospital San Antonio de Chía se pondrán al día y esto lo estaremos evidenciando sobre el mes de agosto septiembre Honorables Concejales para que nuevamente puedan ustedes hacerle control político a este compromiso que tiene el consorcio con respecto a la ejecución de la reposición total de la infraestructura de nuestro Hospital San Antonio de Chía.

Con respecto a aseguramiento para hacer un esbozo completo de todas las preguntas que han venido haciendo cada uno de los Concejales y que hace parte de la Proposición número 008 es importante informarles a todos los ciudadanos

del municipio de Chía, que según las estadísticas Dane, que en este momento para el año 2025 sugieren que tenemos una población de 175.200 habitantes, esta es la fuente oficial del Ministerio de Salud y Protección Social que habla del aseguramiento, no es un cuadro de la Secretaría de Salud quien le habla al municipio de Chía sobre su situación de afiliación y que en este momento a diferencia de otros momentos históricos del aseguramiento del municipio de Chía es importante decirle a los ciudadanos que antes se hacía un control sobre el número de afiliados y hoy debido a la crisis en la cual se encuentra sumergida el sector de la salud en cuanto al aseguramiento, en este momento para nosotros el aseguramiento en toda la Secretaría de Salud se considera como la el acceso efectivo los servicios de salud, a las consultas médicas especializadas, a las consultas de medicina general, odontología y demás especialidades.

Adicionalmente a eso a poder tener en sus manos cada uno de los ciudadanos del municipio de Chía, toda la terapia farmacológica que en un momento determinado ha prescrito algún médico tratante desde los gestores farmacéuticos que desde el primer día que nos posesionamos con el Alcalde Leonardo Donoso hemos venido haciéndole seguimiento a todos los gestores de medicamentos y esto es una realidad Honorables Concejales, este seguimiento que se ha hecho desde la Secretaría de Salud a través de un sistema de gestión de auditoría interna que se llama Gaudí el cual es implementado y les solicita a los municipios la Superintendencia Nacional de Salud implementarlo, estamos haciéndole seguimiento precisamente y de ahí después de hacerle seguimiento en el mes de junio del año pasado y la superintendencia estableció que el calendario iba a ser en el mes de abril, para este año la estrategia Gaudí esta auditoría anteriormente era contratada por el municipio de Chía y para nosotros en la Secretaría es fundamental que sea el personal de planta quien tenga en su memoria a través de la coordinación de aseguramiento todo el aseguramiento del municipio de Chía, se hace auditoría interna a cada una de las EPS con todos los indicadores que sugiere esta estrategia y son ellos los que traen todos los resultados de esta auditoría y de esa manera hacemos mesas interinstitucionales, haciéndole seguimiento a todas las deficiencias que tiene cada una de las EPS con respecto a la prestación del servicio de salud en el municipio de Chía.

Se hacen reuniones virtuales y reuniones presenciales con todas las EAPBS presentes en el municipio de Chía y acompañadas cada una de ellas de los gestores de medicamentos de cada una de ellas con quienes tienen contrato, para verificar todos los temas de medicamentos pendientes, medicamentos desabastecidos y estrategias como fármaco similares precisamente cuando hay un medicamento desabastecido lo que hemos solicitado a cada una de las EAPBS es que sus médicos tratantes analicen las lista de medicamentos desabastecidos hagan homologación en los casos que se puede porque hay muchos medicamentos de control, medicamentos para enfermedades crónicas, sobre todo psiquiátricos y neurológicos que no permiten un cambio de molécula farmacológica. Para continuar con el tema de aseguramiento y me permiten si ustedes a bien lo tienen Honorables Concejales voy a darle la palabra a la Doctora Mónica para que nos devolvamos al tema del Hospital San Antonio de Chía y de esta manera pueda darle respuesta a los diferentes Concejales y en especial a la pregunta que generó el Concejal Pablo Andrés Castro.

SEÑORA MÓNICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS, JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Muy buenas noches para todos Honorables Concejales, a la Mesa Directiva, demás Concejales, a mis compañeros de gabinete, las personas que nos acompañan en barras y a las personas que nos siguen en redes sociales. Efectivamente Concejal Pablo en la proposición que derivó en el control político del 28 de febrero del año



pasado la pregunta que hizo en ese momento el Concejo Municipal a través de ese cuestionario era ¿Cuál era la óptica que en ese momento tenía la Administración en cuanto a la viabilidad técnica, financiera y jurídica de haber efectuado una inversión en una infraestructura hospitalaria sobre la red departamental y específicamente con recursos del crédito? Para absolver la pregunta que se formuló en este nuevo control político, hice nuevamente el ejercicio no solo de la revisión de lo que se ha efectuado ahorita desde la Administración Municipal, sino que volví a escuchar toda la grabación de ese 28 de febrero.

Efectivamente Honorables Concejales si se escucha la sesión completa cuando se da respuesta a esa pregunta una vez los Honorables Concejales toman nuevamente el uso de la palabra la Concejal Angélica Montañez, el Concejal Valdivieso y el Concejal Salgado preguntaban si dentro del análisis que estaba efectuando en ese momento la Administración Municipal se había tenido en cuenta la Ley Estatutaria 1751 del 15 a su vez el Concejal Andrés Vela me preguntó en ese momento que cómo se estaba haciendo ese análisis respecto de la inversión de los recursos del empréstito y se presentó el orden cronológico de lo acaecido desde que se solicita ante la Corporación esa facultad, hasta que se suscriben los contratos derivados precisando que el municipio no es el extremo contratante ni del contrato de obra ni el de interventoría.

A su vez la Concejal Angélica eh me solicita que por favor no pierda de vista la Ley Estatutaria toda vez que el servicio de salud es un servicio público esencial y en ese momento preciso que ese es el análisis que deviene efectuando hasta ese momento, pero que no es una decisión definitiva de la Administración que haya algún vicio de ilegalidad respecto del convenio y el Concejal Pablo Castro me solicita que por favor continúe con el estudio jurídico juicioso del caso y el Concejal Vela me solicita que en el evento de advertir cualquier anomalía haga uso no solo los mecanismos a que hubiere lugar, sino que cumpla evidentemente con la función que me asiste por ser servidora pública.

A partir de ahí efectivamente la Administración Municipal continuó con las mesas de trabajo el día 14 de mayo del 2024 el señor Alcalde, el Doctor Óscar Rojas y la suscrita nos hicimos presentes en la Gobernación de Cundinamarca y fuimos atendidos en ese momento por el Secretario de Hacienda del departamento y se efectuó la revisión del convenio. Efectivamente la lectura que hice en su momento del Artículo 76 de la Ley 715 del 2001, obedeció a la respuesta que yo le brindé en su momento al Concejal Vela respecto que el análisis estaba haciendo era con base a la parte considerativa del Acuerdo 190 que era el objeto del control político, más la parte considerativa del convenio, en ese momento lo que si les puedo decir es que ni en el Acuerdo Municipal ni en el convenio tripartito se hace referencia a la Ley Estatutaria.

Ese sustento jurídico no está presente en el documento como tal, sin embargo, no puedo obviar el hecho de que existe la ley. A partir de ahí nosotros hacemos toda la revisión con el Secretario tanto del municipio como del departamento y más allá Concejal Pablo, de si era o no viable la inversión del recurso el reparo que se tiene es la forma en que se hizo la inversión del recurso, precisamente por ser recursos del crédito. En esa misma sesión del 28 de febrero el Doctor Óscar Rojas explicaba que era diferente haber solicitado el desembolso al banco de forma gradual conforme al avance de obra a la forma en que se hizo en su momento, en un único desembolso a una cuenta de ahorros que posteriormente fue trasladada a una fiducia, el reparo no está en el instrumento jurídico y en su momento creo que también se lo precisé en esa sesión al Concejal Vela, cuando le dije que en ese momento nosotros estábamos trabajando bajo la presunción de legalidad, tanto del contrato como del acto Administrativo que es el Acuerdo Municipal.

En ese orden de ideas Concejal Pablo lo que se hizo desde el 14 de mayo del 2024 fue unas mesas de trabajo con el departamento, porque a nosotros desde el tema contractual no en el escenario judicial porque el convenio no ha sido demandado, el convenio es ley para las partes, se hizo el análisis a la luz del Artículo 1602 y subsiguientes del Código Civil, es el tema del manejo del recurso por los intereses que se están causando mes a mes y que el municipio debe reconocer sobre ese desembolso que se hizo.

En estricto sentido Concejal Pablo usted sabe que más allá de la discusión de la legalidad del instrumento jurídico el hecho cierto es el desembolso del recurso de un crédito que se solicitó, que se cumplieron las condiciones del desembolso fueren las que fueren, cumpliendo la única obligación contractual derivada del municipio en el convenio tripartito que era el desembolso del recurso, por eso después de unas mesas de trabajo se logró ya la suscripción del modificatorio 2 del convenio y se modificó esa cláusula. En ese momento yo les explicaba que conforme el clausulado de ese convenio, los rendimientos que degeneraran por los recursos estando en esa fiducia solo iban a ser retornados al municipio hasta la liquidación del convenio; situación que se puede dar en el 2027 que es hasta cuando está vigente el convenio en estricto sentido o incluso en el 2028 dependiendo de los términos de liquidación, porque primero deben ser liquidados los contratos derivados y de forma posterior el convenio que le da vida a los mismos.

El 10 de abril de este año se suscribió el modificatorio y la cláusula tercera de dicho convenio quedó modificado para que mensualmente dentro de los 10 primeros días del siguiente mes, de acuerdo con el aporte del municipio se haga el retorno de los rendimientos que se causen para que ya presuntamente se pueda continuar con el pago de los intereses eh que causa el empréstito. No, porque recuerden que en ese momento también les comenté que hubo un modificatorio uno al convenio y los aportes del departamento son mayores ¿Qué es lo que pasa? Que como todos los recursos van a la misma a la misma fiducia debe ser a prorrata de los aportes, se tienen que entregar financieramente el estado de cuenta y los rendimientos y se calcula a prorrata y esos son los que van a ingresar al municipio.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente es que quisiera preguntarle a la doctora Mónica, si hay equivalencia entre esos réditos y los intereses que se están erogando de ese crédito respecto de esos 25.000 no respecto ni el aporte de la Gobernación en torno del convenio, ni tampoco respecto de la totalidad del crédito del empréstito de los CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$40.000.000.000), gracias.

SEÑORA MÓNICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS, JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Concejal Pablo la cifra la desconozco, toda vez que la supervisión financiera no está a cargo de la oficina de contratación como tal, el supervisor del convenio no está a cargo de la oficina de contratación, el supervisor financiero es el Doctor Óscar Rojas, la verdad la equivalencia no sé si de verdad supla una cosa con la otra, si mal no recuerdo en esa sesión del 28 de febrero del año pasado el Doctor óscar sí indicó que más o menos los intereses que se estaban cancelando sobre el crédito no sé bien si solo sobre los 25.000 o sobre los el dinero desembolsado, era cercano a los NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$900.000.000) esa consulta sí se la trasladaría yo al Doctor Óscar Rojas.

Ahora respecto de si se ha iniciado algún proceso eh o algún procedimiento sancionatorio en materia contractual a la luz del Artículo 86 de la 1474, a hoy la



oficina de contratación no ha recibido ningún informe por parte de ninguno de los 2 supervisores la Doctora Luz Stella o el Doctor Óscar Rojas respecto a algún incumplimiento de las otras 2 partes suscribientes dese convenio, es decir, departamento u hospital, a hoy la oficina de contratación de acuerdo con su competencia no ha dado inicio a ningún proceso sancionatorio en materia contractual, muchas gracias.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Presidente dando continuidad a las preguntas formuladas por los Honorables Concejales y habiendo aclarado en la duda que tenía el Concejal Pablo Castro continuamos con la presentación y con las respuestas a las diferentes preguntas que nos han formulado. De igual manera también para proteger la atención de los servicios de salud hemos implementado en la Secretaría de Salud una estrategia que ha sido muy favorable para los ciudadanos del municipio de Chía y así lo evidenciaba el procurador provincial en una visita que hizo acompañado de nuestro personero el Doctor Daniel Moyano, esa ola de dificultades que hubo durante mucho tiempo en los medios de comunicación con respecto al acceso a los medicamentos, se presenta efectivamente en un menor porcentaje a pesar de que esto es una problemática nacional en el municipio de Chía ¿Por qué? Por esta estrategia llamada enlaces, es un equipo de colaboradores de la Secretaría de Salud entre ellos trabajadores sociales y ellos se dirigen precisamente todos los días de acuerdo a una planeación y a un cronograma que se establece a los diferentes gestores farmacéuticos en los horarios pico, de cuando normalmente los usuarios hacen acceso a los servicios de los gestores farmacéuticos y esto obedece precisamente a un seguimiento que se hizo el año pasado en el 2024, se identificaron los días durante la semana en donde se presentaban mayor número de usuarios en los gestores farmacéuticos y de esta manera se fueron implementando los diferentes cronogramas en cada uno de ellos, sobre todo en los primeros días del mes que es cuando los enfermos crónicos hacen nuevamente la solicitud de sus medicamentos en estos gestores farmacéuticos.

Adicionalmente eso el equipo de enlaces está en las horas pico de las urgencias de las 4 IPS hospitalarias que es de 6 a 9 de la noche y sobre todo los lunes de 6 de la mañana a 9 de la mañana en urgencias, haciendo precisamente un enlace entre el paciente, su acompañante y adicionalmente también ante la EPS o la IPS hospitalaria en los casos que se tienen muchas veces autorizaciones que no se han emitido por parte de la EPS y esto dificulta el proceso de referencia y contra referencia en las diferentes IPS hospitalarias.

El SAC que es el Servicio de Atención al Ciudadano, precisamente también está de manera permanente vigente en la Secretaría de Salud atendiendo y durante el año 2024 tuvimos radicadas 900 quejas, en las cuales se sistematizan, se establecen por causal, por EPS por número de usuarios edades y demás y encontramos que un 42% sugiere que estas quejas y reclamos de los usuarios del municipio obedecen precisamente a la atención en medicina especializada, a la oportunidad de este tipo de consultas y de igual manera también a la adquisición de los medicamentos a través de los gestores farmacológicos.

Lo que hacemos es emitir unos comunicados a las EPS y ellos contestan directamente a cada uno de los usuarios y nosotros con el seguimiento de persona por persona y dándole cierre a cada caso cuando se logra el éxito, sabemos que de las 900 quejas PQRS radicadas en la Secretaría de Salud se ha dado un porcentaje del 98% de efectividad, es decir que los usuarios han recibido la atención solicitada por ellos a través de sus EAPBS.

Recordemos que la Secretaría de Salud de Chía no hace atención en salud y adicionalmente a eso no tiene funciones de asegurador por eso lo que nosotros hacemos es hacerle el seguimiento a este tipo de quejas e ir verificando que haya efectividad en la atención por parte de la EAPBS en el municipio de Chía. Precisamente esto es un trabajo mancomunado también con toda la Dirección de Salud Pública, porque la Dirección de Salud Pública es quien canaliza todos aquellos pacientes que requieren atención efectiva a través de sus IPS y a través de los procesos Administrativos que otorgan las EAPBS.

Con respecto al seguimiento con respecto al seguimiento del crecimiento de aseguramiento en el municipio de Chía podemos ver y estas son cifras del Ministerio también de Salud, como para febrero del 2025 se había disminuido un poco la afiliación al régimen contributivo con una diferencia de 198 personas, recordemos que el aseguramiento en salud depende de todos los determinantes sociales y económicos que tiene la población, el hecho de que en un momento determinado haya desempleo esto afecta inmediatamente las estadísticas del régimen contributivo y la afiliación y son estas personas precisamente quienes a través del desempleo debemos nosotros inmediatamente abordar para afiliarlas al régimen subsidiado, mientras que nuevamente hacen la consecución de sus empleos. Es así que durante la vigencia del 2024 en el municipio de Chía se alcanzó un total de 179.848 personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud de las cuales el 83.15% pertenecen y están afiliadas al régimen contributivo el 15.89% al régimen subsidiado; de estas 1,707 registran afiliación a regímenes excepcionales o especiales como son las fuerzas armadas el magisterio y demás.

La financiación del régimen subsidiado, nosotros hemos entregado al Concejo Municipal una ejecución financiera detallada en toda la presentación de las repuestas al cuestionario ¿Por qué? Porque precisamente ustedes como Concejales tienen la misión de hacer control sobre todo financiero de los recursos que se están invirtiendo en las diferentes Secretarías y siendo hoy el objeto la Secretaría de Salud es importante que tengamos que se ha hecho una inversión para el financiamiento del régimen subsidiado para la vigencia del 2025 de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$44.275.306.380) y como nos encontrábamos en ese momento en el mes de marzo cuando dimos resta a este cuestionario llevábamos de ejecución un 24.01% es decir lo que obedece a DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$10.629.284.084) es siendo el indicador para una gestión Municipal más importante y relevante la afiliación al régimen subsidiado no por esto no es menos importante que promovamos a través de campañas y evitemos la evasión y la ilusión al régimen contributivo.

Adicionalmente se hace un enlace entre la coordinación de aseguramiento y el equipo de la Dirección de Vigilancia y Control que hacen las visitas a todos los establecimientos comerciales, para verificar que los establecimientos los propietarios de los diferentes establecimientos comerciales tengan afiliado a todo el personal, a sus empleados precisamente al régimen contributivo para evitar precisamente la evasión y la ilusión. Es así como hemos venido también incrementando este porcentaje de acuerdo a la meta establecida en nuestro Plan de Desarrollo. Con respecto a la ejecución acá vemos cómo estamos haciendo todas las visitas de enlaces precisamente para asegurarle la accesibilidad de los servicios de salud y disminuir las barreras de acceso Administrativas que en este momento de crisis del sector de la salud vienen implementando las diferentes EAPBS y muchas veces también desde el Ministerio de Protección Social.

Con respecto a la pregunta de SISPI correspondiendo esta pregunta precisamente también a todo el tema del aseguramiento y cómo se interrelaciona y se articula el sistema pluricultural indígena al sistema de aseguramiento precisamente del



municipio, tenemos quien este momento ya se hizo la mesa técnica con la mesa Mesinchía en el mes de febrero y la mesa sub técnica también se reunió ya con la gobernadora y con el enlace de salud de nuestro resguardo indígena ubicado en la verdades de Fonquetá y Cerca de Piedra y se estableció por parte del gobierno local una suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000) para invertirla en el avance y consolidación de la primera fase de la guía de implementación del sistema indígena de salud propio e intercultural SISPI para el Resguardo Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra en la vigencia 2025.

No podemos de ninguna manera tampoco desconocer y desproteger también a esta importante población que también latinemos articulada de manera transversal en las diferentes metas del Plan de Desarrollo de la Secretaría de Salud para que accedan a todas las actividades de promoción y prevención, vigilancia epidemiológica, inspección vigilancia y control y adicionalmente también a eso a todo lo que tiene que ver con estrategias de zoonosis que tenemos en el municipio de Chía.

Continuaremos trabajando como ustedes lo ven articuladamente con nuestra gobernadora Gina Socha y ya estamos en este momento en la etapa precontractual del SISPI a través de un convenio interadministrativo que se ejecutará precisamente con el Resguardo Indígena para poderle dar cumplimiento y avance a esta meta de manera acompañada articulada, de igual manera también con la asistencia técnica de todos los epidemiólogos y todo el personal especializado de la Secretaría de Salud.

Con respecto a los sistemas de información en salud que nos preguntaban los Honorables Concejales está una herramienta importantísima es Si Te Sigo que precisamente es la vigilancia epidemiológica de todos los eventos de interés pública que en un momento determinado se puedan presentar y en momento real a través de la Secretaría de Salud, recordemos que la notificación la hacen son las IPS y no la notificación la hace la Secretaría de Salud, perdón Si Vigila precisamente porque si vigila lo que permite es hacer una vigilancia epidemiológica de todos los eventos de notificación obligatoria y en este momento de notificación súper obligatoria como lo ha declarado el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a la fiebre amarilla.

Si Vigila es un aplicativo tecnológico que está siendo alimentado de manera permanente con todos los eventos de notificación por parte de las IPS prestadoras de servicios de salud presentes en el municipio de Chía, que tienen un seguimiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca cuando así mismo le llegan todos los reportes que allí se mantienen. Si Te Sigo es la herramienta que sigue toda la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y que en este momento ha venido siendo reemplazado por el sistema de información PIP y hay es importante tener en cuenta que el PIB en este momento se encuentra cargado por parte de la Secretaría de Salud en un 100% con los 4 programas de la Secretaría de Salud y esto lo puede evidenciar y también de igual manera certificar la Secretaría de Planeación del municipio de Chía.

Mango es un herramienta que hace el seguimiento completo a todo el estado nutricional está implementado al igual que Survey por parte de la Gobernación de Cundinamarca y son ellos quien nos va entregando todos los casos que debemos abordar cuando hay problemas de nutrición, sobrepeso, obesidad y demás; nosotros estaremos haciéndole llegar todos los el seguimiento cuantitativo a la Honorable Concejal Angélica Montañez de todos los indicadores que tenemos y nuestras epidemiólogas harán los análisis correspondientes.

Sicriessan es un sistema de información que lo que está implementado a nivel local por el municipio de Chía, este año pretendemos hacerle una actualización y este



sistema lo que hace es hacer un seguimiento a todos los conceptos sanitarios emitidos por la Dirección de Vigilancia y Control de nuestra Secretaría, al igual que Survey no solamente hace el seguimiento de la afiliación al régimen contributivo de algunos indicadores de notificación obligatoria que se requiere de la Dirección de Salud Pública, también es allí donde nosotros hacemos todas el registro de toda la vacunación antirrábica, de todas las acciones de seguimiento a animal agresor y demás estadísticas y por eso precisamente tiene que estar al día para precisamente tomar decisiones de planeación por parte de la Secretaría. Adres, Pisis y el DNP son plataformas del nivel nacional que lo que hacen es el seguimiento a todas las indicadores de aseguramiento que tenemos en este momento en el municipio de Chía.

Ahora bien, hay algo muy importante con respecto al PAE y este programa de alimentación escolar lo que le determina, no solamente el Decreto 40 sino toda la normatividad vigente al respecto a las Secretarías de Salud Municipales es precisamente hacer vigilancia y control de las condiciones sanitarias y de inocuidad alimentaria que debe tener este importante programa no solamente para el municipio de Chía, sino para todos los niños niñas y adolescentes eh colombianos y aquellos migrantes que han llegado a ser parte de nuestros colegios Municipales.

Hasta el momento hemos realizado 52 visitas de Inspección Vigilancia y Control adicionalmente a eso 54 vigilancias a la entrega de la ración industrializada, no solamente aquellos planteles que tienen ración industrializada porque no hay presencia de cocinas, sino también cuando tenemos que tomar alguna medida como fue la medida en el colegio de Fonquetá, que a este colegio le solicitamos al operador del PAE a través de la Secretaría de Educación que entregara raciones industrializadas mientras que se hacían unas mejoras a la infraestructura precisamente de las cocinas y los comedores del colegio de Fonquetá.

De igual manera también se ha hecho vigilancia la entrega de reacción industrializada a los colegios: El Diversificado, Fusca, colegio Santa María del Río Sede A y Santa María del Río Sede B. El muestreo de alimentos que también es una obligación de la Secretaría de Salud frente al PAE ha sido un muestreo de 14 envíos a los laboratorios de salud pública y en estos muestreos ninguno presentó riesgo con respecto a los alimentos que allí se estaban distribuyendo, hemos hecho educación sanitaria permanente, precisamente para las personas que hacen parte del operador del PAE y también para toda la comunidad educativa que interviene de manera articulada con el programa de alimentación escolar en cada uno de los planteles educativos Municipales y cuando tenemos hallazgos se hace comunicación a la Secretaría de Educación Municipal y al operador del PAE de manera inmediata y también tenemos seguimientos permanentes por parte de la Personería delegada y se están emitiendo conceptos al igual que estuvimos acompañando a la Secretaría de Educación en la visita que le hizo el Procurador Provincial y el Procurador de Agado durante esa visita ellos evidenciaron el cumplimiento total de las obligaciones que como Secretaría de Salud tenemos frente a la implementación de este importante programa.

Aquí podemos ver diferentes intervenciones que hacemos eh todo tiene que ver con infraestructura obviamente, buenas prácticas de manipulación de alimentos que se estén llevando a cabo, todos los planes de saneamiento que la Secretaría de Educación tenga que implementar y adicionalmente a eso se emite un concepto sanitario, que si bien es cierto osciló durante el año pasado de un 72% a un 85% en cada uno de los planteles como se evidenció a lo largo del cuestionario que nosotros emitimos al Honorable Concejo Municipal; la inocuidad de los alimentos ha sido algo fundamental para la Secretaría de Salud y todo su equipo de Ingenieros de Alimentos y la Dirección de Vigilancia y Control el 7 de junio del año pasado no solamente conmemoramos el día mundial de la inocuidad de los alimentos, sino que hicimos un foro en donde estuvieron más o menos 150 empresarios del sector

gastronómico del municipio de Chía y allí hicimos una muestra a través de Fedegan y diferentes asociaciones que nos acompañaron para proteger la inocuidad de los alimentos que no solamente se realizan estas gestiones de educación sanitaria en los diferentes escenarios como foros y seminarios, sino que todo el equipo de los ingenieros de alimentos y los ingenieros ambientales que hacen parte de la Secretaría de Salud tienen que estar permanentemente haciendo educación sanitaria a los 5.000 establecimientos que se tienen en el Plan De Desarrollo, cuando nosotros decimos que la meta son 5.000 establecimientos podrán tener muchos establecimientos varias visitas, sobre todo cuando el concepto sanitario es favorable con requerimientos o ha sido desfavorable, son muchas más visitas de mantenimiento que la Secretaría de Salud pero como la meta está contemplada es por número de establecimientos por eso no estamos mencionando cuántas veces hemos ido a cada uno de ellos para hacerles seguimiento y lograr que ya lo vamos a ver cambios importantes y estructurales en los establecimientos comerciales. No solamente de alimentos sino también de diferentes actividades del sector económico en el municipio de Chía, con evidencia es que la Secretaría de Salud viene hablando precisamente.

A esto del PAE viene también unido el control de roedores que es precisamente cuando hacemos control de roedores y se presenta un plan de manejo ambiental lo que queremos evitar son enfermedades zoonóticas como por ejemplo la leptospirosis que es la que se contagia a través de los roedores y en el PAE es bien importante tener este control de manera permanente haciendo identificación de factores de riesgo el INVIMA la Secretaría del Ministerio de Salud y Protección Social implementó después de muchos años gestión de vigilancia y control a establecimientos a través de la gestión del riesgo nosotros lo que tenemos es que ir y verificar cuáles riesgos son los que existen en cada una de las visitas a los establecimientos, de estado esta manera y de manera educativa de acompañamiento en muchos casos debemos a ese empresario acompañarlo para que haya una mejora en su establecimiento y así evitamos los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos en nuestra población del municipio de Chía.

Cuando evidenciamos control de roedores en alguna institución educativa y esto es precisamente porque hay presencia de alimentos, por las podas, por la condición de la infraestructura porque muchas veces no se tiene dentro de las instituciones y no todo es inversión en infraestructura Honorables Concejales muchas veces es educación a los rectores y a los diferentes docentes para que mantengan la infraestructura que se tiene y que en este momento está siendo renovada por voluntad del Alcalde Municipal, mientras tanto que esté en condiciones adecuadas de saneamiento, adecuadas de limpieza, adecuadas de desinfección y esto lo puede hacer conjuntamente también muchas veces la comunidad educativa.

Precisamente nosotros antes de iniciar todo en el periodo académico de este año se hicieron 22 intervenciones para todo lo que tiene que ver con fumigación y control de roedores en cada una de las instituciones educativas y durante el segundo semestre con nuestro operador hicimos las aplicaciones, intervenciones y re intervenciones muchas veces sobre todo a la institución educativa de Fonquetá y Laura Vicuña precisamente para controlar los roedores y controlar la permanencia de mosquitos, de plagas y vectores que se presentó durante el año pasado.

Esto es una evidencia que en muchas instituciones educativas se encuentran factores de riesgo que no solamente se tienen que controlar a través de una nueva infraestructura física de los planteles educativos, claro que sí hay que mejorar la calidad de ellas y ya ustedes han hecho una amplia presentación de esto, pero es importante tener en cuenta que también los planteles educativos deben estar podados adecuadamente, muchos de ellos tienen por ejemplo y hemos evidenciado en las diferentes visitas matas de calabaza que esto es un alimento apreciadísimo

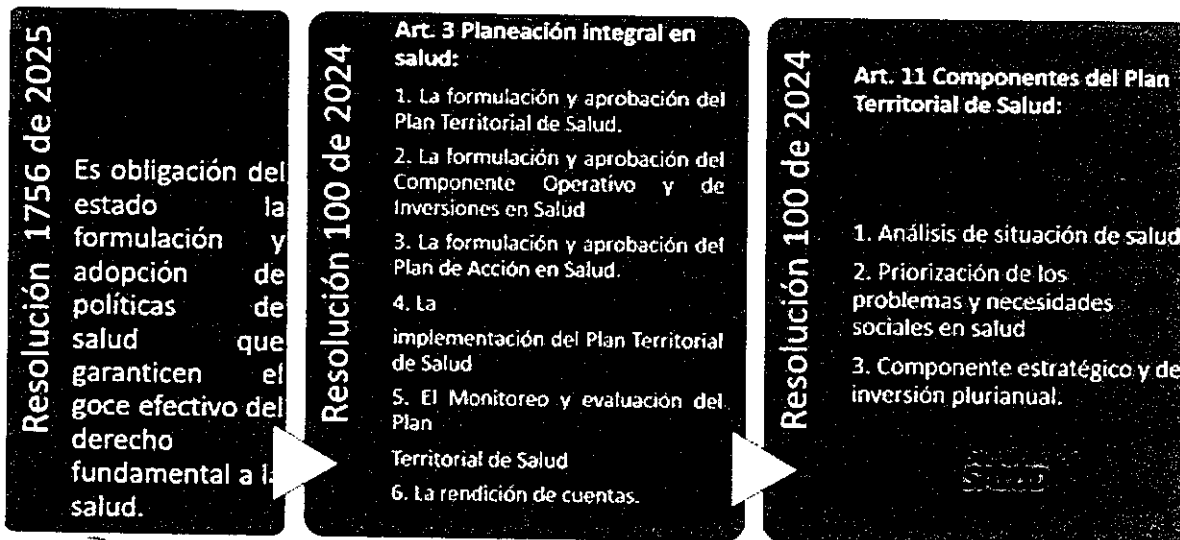
por los roedores. Adicionalmente la inadecuada disposición de los residuos sólidos y miren ustedes como muchas veces encontramos condiciones inadecuadas de limpieza y desinfección en estos planteles educativos.

Ahí ya hicimos la intervención de manera conjunta con el equipo de podas de la Administración Municipal haciendo educación sanitaria cada uno de los planteles educativos a través del operador que implementa el plan de manejo integral de plagas, haciendo la intervención y adicionalmente haciendo educación sanitaria de manera permanente en cada una de las instituciones educativas.

Ahora vamos al conjunto de la planeación del sector de la salud la planeación del sector de la salud tiene 2 componentes fundamentales acompañados obviamente del plan operativo de inversiones que es muy importante obviamente para darle realidad a las acciones que en este plan territorial y en el PAS que es el Plan De Acción En Salud se instauraron y se implementaron

Pregunta 11 y 15

Plan Territorial y Plan de Acción en Salud



En la Resolución 100 hablan perfectamente del Plan Territorial de Salud y le pido el favor a Laurita que me pase la siguiente diapositiva porque precisamente en la resolución habla que la aprobación del plan territorial de salud debe ser integral con el Plan De Desarrollo y Honorables Concejales el año pasado cuando ustedes hicieron la aprobación del Plan De Desarrollo para el cuatrienio 2024-2027 precisamente ustedes también aprobaron el plan territorial de salud que fue también objeto de una larga discusión aquí en este recinto, es así como es aprobado a través del Acuerdo 219 de 2024 y las actualizaciones del análisis de situación de salud que es el Asis siempre van con una anualidad de acuerdo a la normativa precisamente haciéndole seguimiento al análisis de la situaciones de salud en el municipio de Chía y de todos los factores determinantes, no solamente de salud pública sino también ambientales y demás y precisamente esto es lo que nosotros hemos implementado.

Vamos a pasar rápidamente el plan la ejecución del plan territorial de salud que al Honorable Concejo se le contestó en el cuestionario más o menos, esto hacía parte de las 475 hojas de respuestas, eran más o menos 37 hojas precisamente porque en el PAS y en el seguimiento del Plan Territorial de Salud se debe establecer cada una de las actividades estrategias y demás contenidos en el Plan De Desarrollo y allí mismo en una columna a los Honorables Concejales les ubicamos toda la ejecución financiera y la ejecución en cuanto a coberturas y al indicador de coberturas que se implementó, ya nos van a pasar esto porque me parece

importante Concejal Angélica usted mencionaba que había sido un copy page, no ahí está cada una de las actividades, fue un trabajo bien articulado con el equipo de la Secretaría de Salud precisamente para entregarles un informe detallado en lo que para ustedes es algo muy importante que es la ejecución presupuestal de cada una de las estrategias y actividades incluidas en nuestro Plan Territorial De Salud y sobre todo en nuestro Plan De Desarrollo Municipal.

Aquí en este documento que hace parte del cuestionario cada una de las metas contenidas en el Plan Territorial De Salud y que hacen parte también del PAS van identificadas cada una de ellas con: ejecución, fuente de financiación, porcentaje de ejecución de cada una de las actividades el porcentaje de ejecución financiera como lo mencionaba anteriormente, este documento más o menos son 17 hojas que menciona cada una de las actividades que tenemos diseñadas para el Plan Territorial de Salud y el PAS. De igual manera es importante mencionarle al Honorable Concejo Municipal que se ha radicado también de acuerdo al cumplimiento ante la Gobernación de Cundinamarca y entes de control eh los documentos que debe contener eh la anualidad y la certificación que debe emitir la Gobernación de Cundinamarca para la radicación oportuna y nunca extemporánea del plan de atención en salud y de nuestro plan territorial de salud, volvamos por favor a la presentación de PowerPoint, por favor. Esta es precisamente el acta del Consejo de Gobierno que acompaña el PAS y el Plan Territorial de Salud con todo su componente operativo de inversiones, que se debe presentar ante el Consejo de Gobierno y fue efectivamente realizado para que se diera aval por parte del gabinete del Alcalde con respecto a todas las acciones que iba a desarrollar la Secretaría de Salud.

Ahora bien vamos a nuestro mencionado PIC que es el Plan De Intervenciones Colectivas que al respecto tenemos varias preguntas y que hace parte del modelo de atención primaria en salud, que en este momento se está implementando a nivel nacional. El modelo de atención primaria en salud, es un modelo de atención preventivo, predictivo y es así como lo define toda la normatividad que hace al respecto y que a través de este modelo de atención se debe atender de manera primaria a toda la población de manera universal gratuita y de manera obligatoria por parte de todos los actores de salud, así bien dentro de ese modelo de atención en salud primario que en este caso tengo que decirlo debería ser un modelo de atención primaria social, porque muchas veces encontramos problemáticas de salud que por más que lo queramos intervenir a través de los equipos y el talento de salud precisamente hay indicadores y hay factores sociales que no permiten que las personas entren a un estado y a una condición saludable.

Este modelo de atención primaria tiene un componente importante para los municipios, como el de Chía que es un municipio no descentralizado en salud por el momento, en caso tal de que llegara a haber una reforma en salud ya obviamente nuestra actuación pasaría a ser muy diferente, ya pasaríamos a hacer cabs, a manejar el Fondo Local de Salud de una manera diferente, pero ese no es el caso de esta presentación.

El plan de intervenciones colectivas durante el año 2024 de acuerdo a la resolución correspondiente efectuó, la contratación con el Hospital San Antonio de Chía al día, es decir, antes del 31 de marzo del 2024 con un valor inicial de:

Contrato CO1.PCCNTR.6147085	
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	
Valor Inicial =	\$2.885.349.800
Adición =	\$262.136.893
Valor Final =	\$3.147.486.693

Con un equipo interdisciplinario de 106 personas en el PIC y que adicionalmente a eso lo que buscamos es intervenir todo el entorno de la comunidad del municipio de Chía a través de sus hogares, el entorno comunitario, el escolar, el institucional y el laboral ¿a través de qué? de una división territorial de ocho micro territorios para que precisamente de acuerdo a sus propias características que se comparten en diferentes veredas y sectores urbanos del municipio estuvieran allí un equipo básico de salud compuesto por una enfermera jefe, un psicólogo y cuatro personas auxiliares o técnicas en salud y unos equipos complementarios que estaban conformados por médicos generales, edufisicos, nutricionistas, fisioterapeutas, gerontólogos, optómetras, odontólogos, higienistas orales, bacteriólogas, trabajadores sociales y veterinarios, es así como llegamos a un avance de la meta del 100% si tenemos en cuenta que la meta establecida en el Plan de Desarrollo obedecía a 12.800 familias de igual manera estas 12.800 familias estaban distribuidas en los ocho micro territorios.

El primer equipo básico de salud que está ubicada en:

Territorio De Salud	VEREDAS O SECTORES	POBLACION OBJETIVO
Equipo Básico de Salud 1	Fusca Yerbabuena Bojacá (Oriental)	1.600 FAMILIAS
Equipo Básico de Salud 2 y 7	Bojacá	3.200 FAMILIAS
Equipo Básico de Salud 3	Zona Urbana	1.600 FAMILIAS
Equipo Básico de Salud 4 y 8	Fagua Tiquiza	1.600 FAMILIAS
Equipo Básico de Salud 5	La Balsa	1.600 FAMILIAS
Equipo Básico de Salud 6	Samará, 20 de julio, El Garro Fonsueta Cerca De Piedra	1600 FAMILIAS
TOTAL FAMILIAS: 12.800		

Si vemos el plan de intervenciones por intervenciones en cuanto a enfermedades y dimensiones en salud ahí están establecidas cada una de las coberturas que hicimos en las diferentes dimensiones como salud oral, cáncer salud AIEPI salud mental y demás.

El plan de intervenciones colectivas del 2024 también llevó consigo dos grandes brigadas de salud la primera se realizó el 6 de abril de 2024 y el 7 de septiembre de 2024 con un total de personas sensibilizadas en estas dos grandes brigadas una fue ubicada en el parqueadero de la biblioteca Oqabiga y la otra gran brigada se ubicó en el Parque de las Flores que fue también en donde tuvimos la presencia de la Universidad de la Salle, se articularon las EAPBS, de igual manera también muchas IPS y gestores farmacéuticos que se acercan para precisamente brindar servicios de salud de promoción y prevención que es nuestro enfoque para el municipio de Chía.

Con respecto al plan de intervenciones colectivas planeado para el 2025 y que se le dio inicio el primero de abril de este año:



**Estrategia "Casa A Casa"**

- Mínimo 9600 Familias
- 5.000 AIEPI (Niños y Niñas)
- Salud Mental mínimo 2.500

**Personas en general beneficiadas Mínimo 16.250**

- Sensibilización en enfermedades crónicas mínimo 3.500
- Salud Mental mínimo 2.500
- Sensibilización en Cáncer mínimo 2.900

**Desarrollar dos (2) Grandes Brigadas**

- Ejecutar jornadas de salud en los diferentes sectores
- Estrategia de Salud humano animal







De igual manera también debemos intervenir salud mental como uno de los objetivos más importantes de todo nuestro Plan de Desarrollo a 2.500 personas a través de las diferentes estrategias de salud mental las personas en general beneficiadas serán mínimo 16.250 personas a las que le llegaremos cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio sensibilizando en enfermedades crónicas mínimo 3.500 usuarios porque es allí en los enfermos crónicos también aquellas enfermedades psiquiátricas y neurológicas donde encontramos realmente el cambio del perfil epidemiológico cuando pueden acceder a sus múltiples consultas médicas, médicas especializadas y de igual manera también a su terapia farmacológica y a todo el arsenal terapéutico que tiene nuestro sistema de salud.

Desarrollaremos dos grandes brigadas la primera la vamos a llevar a cabo el 17 de mayo en nuestro polideportivo de Samaria ¿por qué ubicamos en Samaria? porque el año pasado estuvimos en el casco urbano de igual manera también el sector de Bojacá y evidenciamos que una de las dificultades más grandes que tenía la pregunta dos que en las brigadas o en todo el Plan de Desarrollo de la Secretaría de Salud ¿cuál era una de las dificultades más grandes? la convocatoria que se debe hacer a toda la población y Samaria ha respondido muy bien a todas las estrategias que hemos implementado en la Secretaría de Salud con las esterilizaciones, adicional quirúrgicas de caninos y felinos de igual manera también con toda la vacunación antirrábica toda la vacunación con respecto al PAI que tenemos también que ofrecer, todos los certificados de discapacidad, la entrega de hortésicos y demás actividades que desarrollamos desde la Secretaría de Salud, recordemos que estas dos grandes brigadas hacen parte de un concepto fundamental del cual hemos venido hablando durante este año y 4 meses y corresponde precisamente a un concepto que es una sola salud y una sola salud es que haya salud pública para nosotros los seres humanos y para los seres sintientes, animales de igual manera para poder articular todas estas acciones y lleguemos precisamente a ciudades, entornos y ruralidades saludables y sostenibles de las cual ya les voy a hablar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejala Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente. Es que esta es una presentación de 128 diapositivas y va en la 28 y es lo mismo que ella nos entregó en el informe y es claro y ya lo vimos y está toda la ejecución presupuestal lo que están haciendo, pero doctora Luz Estella yo se lo había dicho antes de este Control Político y es que lo hemos exigido en todos los Controles Políticos y no es por molestar es que usted tiene una Secretaría que

Página 39 de 63





es muy valiosa y que tiene que mostrar y así no se ve todo lo que ustedes hacen y lo que nosotros como Concejales podríamos estar evaluando ¿qué cosas? usted tiene equipos de gestión, tiene equipos que están contratados con el hospital que es todo lo del PIC y mi invitación porque es que nosotros los que creo que todos lo leímos, yo lo leí y vamos a ver lo mismo que tenemos aquí para el Control Político además de la ejecución y todo nosotros queremos saber en qué se ha invertido cada recurso, en qué programa y ustedes lo tienen pero no logro entender por qué no aprovechan a sus profesionales, usted es una mujer excesivamente inteligente pero aquí no se ve nada de lo que realmente hace el municipio, o sea ustedes Concejales supieran todo lo que trabaja el municipio y cómo se ve aplicado a temas de salud pública y la presentación tiene que ser diferente.

El tema no puede ser contar que nosotros hacemos tres brigadas y que entonces el sector de Samaria le va super bien no, aquí tiene que darse el informe y decir, nosotros estamos impactando el sector de salud, salud mental y es que lo tienen yo no logro entender es por qué no lo plasman acá porque eso está en la Secretaría clarito yo lo conozco, lo he averiguado, he estado estudiándolo y está todo yo les pedía venga ustedes tienen equipos de epidemiólogos, ustedes tienen médicos y esa información tiene que estar representada de otra manera, ustedes tienen que decirnos si las enfermedades crónicas son estas, si claro aquí deberían estarnos presentando cuál es la primera enfermedad crónica que hay, cómo la están tratando cómo se ha invertido recursos en enfermedades crónicas cómo hemos impactado el municipio con esas enfermedades ese es el informe real de lo que es salud y hay otras Secretarías que lo han podido hacer tenemos que poderlos hacer en salud y lo digo como colega del sector salud y sé que lo hacen pero acá no se ve y no puede ser que fuimos a tal vereda a donde 2.900 familias sí pero ¿cómo se impactó? ¿cómo esa plata que invertimos en esos programas? está impactando y sé que impacta pero muéstrenlo es que eso es lo que yo quiero en este informe es lo que yo quiero que se vea reflejado, porque lo tienen se ve tan contando la historia de que vamos y mostráramos y sí la doctora Luz Estella es una mujer absolutamente humana, social, pero me parece que están desaprovechando a todos los profesionales para que muestren acá realmente, acuérdense ustedes en la parte pública hay una inversión de recursos y esos recursos dan calidad de vida a los ciudadanos del municipio y yo sé que lo están haciendo porque ahí se ve, pero todas las preguntas que hoy hice era lo que quería que se representara es cómo porcentajes, en el año 2023 pasó esto, en el 2024 en el otro con gráficas que sea fácil para que lo puedan ver todos los Concejales y entiendan porque este tema también es denso o sea esa no es la manera de presentar, preséntenlo con colores, con temas estadísticos para que nosotros veamos y ustedes tienen un observatorio ¿qué resultados tiene ese observatorio? yo le creo que hizo esas preguntas cuando estábamos en la sesión ¿cómo? porque es que nosotros los Concejales tenemos que entender todos no solo yo todos cómo se están invirtiendo esos recursos y créanme que Chía tiene un escenario muy positivo frente a los temas de salud, pero muéstrenlo.

Yo quiero que acá se pueda ver en el Concejo las capacidades de la Secretaría de Salud que son maravillosas, yo por eso pedía que estuvieran acá los epidemiólogos que ellos además presentan unas tablas, presentan unos informes, presentan todos los temas de lo que está pasando con fiebre amarilla que aunque somos un municipio que no es endémico pero hay que vacunar a cierta población que viaja, esos temas para nosotros son importantes porque es que nosotros somos el contacto con la comunidad y nosotros somos los que podemos replicar lo que está haciendo el municipio, si nosotros no obtenemos ese conocimiento en estos informes, si ustedes me preguntan hoy con el informe de movilidad cuando hablamos tenemos claro que se han reducido las muertes en accidentes en siniestros viales, tenemos claro que se han disminuido los lesionados menos los de bicicleta y lo sabemos los Concejales y lo podemos llevar al territorio, nosotros también como Concejales necesitamos entender que el debate que hicimos del Plan





de Desarrollo el Plan Territorial de Salud tiene que quedar acá en cifras y nosotros poder entender ¿qué es lo que está pasando con la salud? la salud no es solamente decir que hay alguien que tiene una dificultad colaborémosle, claro esa es la parte humana pero el resultado nuestro Concejales como Administración Municipal es poder tener claras las cifras, tener clara hacia dónde está apuntando todos los temas de políticas públicas, hacia dónde va la salud y lo están haciendo pero no lo logran transmitir, porque hoy parte de lo que yo esperaba como profesional de la salud es que a través de ese informe todos los Concejales lográramos percibir y entender que está pasando de manera clara y las inversiones cómo se están haciendo con todos los programas de salud, pero no se ve o sea no quiere decir que no lo hagan, es que no lo logran transmitir en escenarios de cómo se está impactando.

Yo quisiera escuchar en cuánto se han disminuido los embarazos en adolescentes, cómo ha mejorado, cómo se han aumentado por ejemplo los diagnósticos en tuberculosis, cómo están esos temas que son básicos, que los entendamos para poder entender las dimensiones de las inversiones en salud, allá es donde va lo que yo he pedido y lo he pedido siempre y es pasar a temas claros, inversión de plata en este programa se ha gastado tanto, se logró esto y el impacto que tenemos en la comunidad es tal, estamos mejorando calidad de vida de esta manera, es que ese es el desarrollo que debe tener porque si vamos a volver a escuchar y están respondidas yo ya por eso hice acá una cantidad de contra preguntas pero es que mis contra preguntas es ver cifras frente a inversiones y a resultados a la comunidad o sea nosotros a este nivel no podemos decir, si hicimos tres brigadas nos fue muy bien, la gente respondió bien, no hicimos tantas brigadas en tales sectores, el resultado fue esto y logramos determinar y hemos bajado tales incidencias de determinada enfermedad o hemos logrado avanzar en temas de vacunación y eso ha impactado en la población en esto y esto ya es donde yo quiero que logremos poder referenciar absolutamente todo.

Entonces por ejemplo incidencia de tuberculosis, pásenlo a palabras de logramos que se aumenten los diagnósticos de tuberculosis lo que ha permitido que algunos tanto porcentaje de contactos se diagnostiquen se les dé tratamiento y eso evita que tal porcentaje de las personas sean diagnosticadas a corto tiempo y eso mejora la calidad de vida de las familias, ese tipo de interpretaciones para nosotros entender qué es lo que está pasando en el territorio, nosotros también como Concejales queremos saber y entender los temas de salud y las inversiones en cada programa que se da, pero es que ustedes lo hacen o sea yo sé y lo conozco lo hacen pásenlo a gráficas que nosotros podamos entender, por eso mi solicitud casi de la misma cantidad de preguntas o más de la vez pasada para que no sé si logran entender qué es la información que requerimos para el análisis.

Porque si yo conozco el tema de salud muy bien y todos estos informes, pero yo no entiendo si realmente la plata que se está invirtiendo en salud si se traduce en mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por eso mis preguntas de cómo está el tema de en cifras de todos los temas que yo toqué en este momento de afiliaciones, regímenes para hacerlo claro y lo hacen ustedes tienen que ser más amigables con la información porque es que además ustedes hacen cosas maravillosas, tradúzcanlo en la información para no hacer el documento tan denso y nosotros o por lo menos yo poder entender bien las inversiones que se están haciendo más allá decir esta es la plata aquí se invirtió y se ejecutó el 30% ¿pero cómo? y unas unos análisis de por qué hemos mejorado en todo el sector salud a ver si logro poder, por eso las preguntas a ver si de esa manera la presentación se hace esa de esa manera porque no es tan entendible.

Por ejemplo 45 casos notificados de desnutrición, bien en el tema de seguridad alimentaria, bajo peso al nacer 1.8700 nacimientos registrados bajo peso al nacer perfecto ¿qué hemos hecho con las inversiones que se han hecho para mejorar eso?



**Concejo
de Chía**

allá va el otro pedazo de la información que requerimos allá es hacia donde quiero que esto sea de verdad un Control Político en salud.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Angelica, doctora.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

La manera Concejal Angélica era llegar precisamente a esto ¿a través de qué? estrategias a través del plan de intervenciones colectivas del aseguramiento en salud, a través de esas inversiones que no solamente se hacen con las epidemiólogas de las que usted habla y que de igual manera también aportan en el proceso sino todo el equipo asistencial y el talento humano, no solamente la Secretaria de Salud sino todos los actores del sistema les tocaba explicarle a la comunidad del municipio de Chía que de igual manera yo considero Honorables Concejales que merecen todo el respeto y estar enterados precisamente gracias a esta tecnología que hoy en día tenemos que nos permite explicarle a la comunidad en qué están siendo invertidos sus recursos, precisamente a través de esas estrategias ya mencionadas, llegamos al observatorio de salud y los resultados para el año 2024 y precisamente comparados con el año 2023 obedecen a qué tanto hemos mejorado y qué dificultades hemos tenido en algunos indicadores y por qué el observatorio para infecciones de transmisión sexual nos dice que había un resultado en el 2023 de 42.3 casos por cada 100.000 habitantes en el municipio de Chía notificados y para hepatitis B y C 13 casos notificados ¿qué obtuvimos en el 2024 con las diferentes estrategias que ya les había explicado.

Llegamos a 31.2 casos por cada 100.000 habitantes para VIH sida y hepatitis B y C de 15 casos notificados esto no solamente es con los recursos que se invierten en promoción y prevención, eso tiene que ver con todos los recursos que el país invierte precisamente en nuestro sistema de salud, es decir, que hubo 51 casos notificados para VIH sida y 8 para hepatitis B y 7 para hepatitis C. La seguridad alimentaria y nutricional.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Perdón quiero hacer la intervención precisa.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejal tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente, mi pregunta es listo ahí está y el observatorio solo con un tema ¿qué dice el observatorio de infecciones de HIV? ¿qué conclusión sacaron de eso?

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD





Que todas las rutas de mantenimiento de RÍAS que son las que nosotros hacemos el seguimiento a las rutas integrales de atención en salud estaban dando resultado para este tipo de infecciones de transmisión sexual, cuando todo el equipo y el talento humano de la Secretaría de Salud hace las rutas de atención integral en salud precisamente tienen que arrojar esta diferencia en los resultados, la seguridad alimentaria y nutricional.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

No doctora, espéreme es que eso es lo que a lo que quiero llegar porque en ese caso se sabe cómo sé que la intervención que se hace en un programa de esos sí es buena, porque hay menos casos notificados y si no qué tal no sea por casos notificados puede ser que existan menos casos notificados o más casos notificados ¿hacia dónde voy yo? los casos notificados significan, o sea ahí tiene que haber un detalle adicional más ¿qué casos notificados es qué conclusión sacaron porque yo puedo tener más casos notificados porque aumento el diagnóstico y eso podría ser mal visto porque hay más casos o si hay menos casos es que no estoy.....

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente moción de orden por favor.

Concejal Angélica qué pena, pero yo sí quisiera que le diéramos orden al debate Concejal pena.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Es que tengo una pregunta en ese tema Concejal es que ahí es donde yo quiero explicar por qué quiero que se aumente desde la Secretaría la explicación, porque ahí dice detalle cuando uno está en salud notificados no notificados puede dar muchas interpretaciones y allá es a donde yo quiero ir, es que salga del observatorio no solo los resultados es que ustedes reportan resultados y detalles pero no hay las interpretaciones que impactan para que nosotros entendamos cómo están funcionando el tema de los recursos, allá voy ahí hace falta ese tema y es lo que yo estaba preguntando acá porque no solo decir que hay menos casos o más casos quiere decir que la cosa funcione y les voy a decir algo, que hayan más o menos recursos no quiere decir que una estrategia funcione o no funcione, lo que sí tiene que quedar claro es cómo se está evaluando y yo sí quiero ver los reportes específicos del observatorio frente a cada enfermedad más allá de que casos notificados sí, es lo que usted reporta como a la entidad departamental y lo que cada IPS, pero las estrategias, si ha funcionado, no ha funcionado que son mis preguntas si ha funcionado no ha funcionado o cómo hay que cambiarla entre año y otro año allá es donde va donde uno funciona bien en temas de estrategias de salud, allá voy gracias y no voy a intervenir más.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejal Salgado tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias Presidente, al principio se dijo y nos ha pasado en otros debates que no nos dan el uso de la palabra y escuchamos a los Secretarios, les damos el tiempo



que ellos necesitan para que nos den sus respuestas y después hay otra intervención, entonces hoy se está llevando un debate entre dos personas y así no está programado esto Concejal, entonces dejemos que ella termine su intervención y después sí cada uno hará sus respectivas preguntas, así nos ha tocado o no nos pasó no sé qué día lo mismo Concejal Torres no nos otorgaban el uso de la palabra entonces démosle orden a este debate para que podamos entender todos y claro Concejal está en todo su derecho de preguntar lo que usted tiene que preguntar, pero dejemos que la Secretaria termine su intervención para poder nosotros después intervenir.

Muchas gracias señor Presidente por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Gracias Concejales, sí en efecto solamente pedir a los Concejales y a la Administración que previo que vayan a realizar su solicitud de uso de la palabra que sí por favor sean respetuosos con la Mesa Directiva y le pidan el uso de la palabra directamente a la Mesa Directiva, tiene el uso de la palabra doctora Luz Stella.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Gracias Concejal Vela, bueno con respecto a seguridad alimentaria y nutricional el bajo peso al nacer para el 2023 presentó 102 bebés a término y 120 a pretérmino y lo que correspondió al 2024, 87 a término y 96 pretérmino precisamente cuando tenemos un detalle para el 2024 de 1.178 nacimientos registrados. En cada una de las estrategias se hará de acuerdo a lo que el día de hoy que no estaba en el cuestionario estaba solicitando la Concejal Angélica Montañés la explicación de cada una de las estrategias de por qué se disminuyó y cuáles dificultades existieron en aquellos indicadores que no presentaron disminución para el año 2024, en tuberculosis la incidencia para el 2023 fue de 18.3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y en el 2024 fueron de 9.2 casos nuevos los cuales fueron totalmente manejados a través de los diferentes tratamientos y haciéndoles el seguimiento continuo a cada uno de ellos por parte de la doctora la bacterióloga que tenemos en la Secretaría de Salud contratada para este caso.

En AEPI existieron 4 casos probables de tosferina los cuales todos fueron descartados y también para eventos prevenibles hubo 3 casos probables de tosferina en el 2024 también todos descartados, la tos ferina recordemos que es una enfermedad que se puede prevenir a través de la estrategia de vacunación.

La infección respiratoria aguda con toda la presencia de lluvias y demás que tuvimos durante el año pasado, presentaron 64.562 casos nuevos por cada 100.000 habitantes con una tasa de letalidad del 1% una tasa de mortalidad del 1.2% por cada 100.000 habitantes y precisamente las infecciones respiratorias agudas fueron una de las enfermedades que más colapsó todos los centros hospitalarios del municipio de Chía y se hizo precisamente mesas de seguimiento y de estudio a cada uno de los casos que presentaron mortalidad durante el año 2024 el cual los dos casos correspondieron a situaciones congénitas de las madres y las dos eran madres migrantes en el municipio de Chía.

En cuanto a cáncer de menores de 18 años se presentaron 1.4 casos de leucemia en menores de 15 años es decir 4 casos de cáncer en menores de 18 años para el año 2024 lo cual correspondieron a leucemias linfoides agudas y esto corresponden obviamente también a enfermedades congénitas para esta población. El cáncer de mama y cuello uterino se presentaron 87 casos notificados los cuales fueron



establecidos a través de las diferentes IPS y las notificaciones para un grupo de edad mayor en mujeres de 55 años.

En salud mental, aquí podemos ver entonces cómo teníamos 182 casos notificados y para el 2024 intentos de suicidio 121 casos y durante este año llevamos 8 casos y esto precisamente obedece entre otros a la vigilancia que se estaba haciendo que no se tenía a la ruta de atención integral de salud mental dentro de las RÍAS de mantenimiento del año 2023 para atrás no se le había hecho seguimiento a la RÍAS de salud mental y adicionalmente también a las diferentes estrategias como los centros escucha, la canalización a través de enlaces a los especialistas de cada una de las EPS y de igual manera también la línea de tele orientación en salud mental gatekeepers y demás estrategias que estamos realizando no solamente en la Secretaría de Salud sino también a través del consejero de salud mental que a bien tuvo el Alcalde nombrar desde su despacho.

Precisamente lo que tenemos que intentar es disminuir este tipo de sucesos de interés público, de interés en salud pública en el municipio y es así como lo podemos evidenciar en estas estadísticas. La situación materno perinatal tenemos una morbilidad materna extrema de 134 casos notificados para el año 2023 y a raíz precisamente de los seguimientos de todas las gestantes de alto riesgo y mediano riesgo que vamos realizando por parte del talento humano de la Secretaría de Salud llegamos a una morbilidad de maternidad extrema de 99 casos durante el año 2024 y mortalidad perinatal y neonatal tardía de 10 casos notificados es decir 7.5 casos, cada uno de estos casos se le hará una reseña caso por caso Honorable Concejal para que entienda cuál fue de manera individual cada una de las estrategias porque aquí no puede haber una estrategia de manera común sino que debe ser individual y en un programa completo a través del seguimiento casa por casa de los eventos notificados por las IPS y por la Gobernación de Cundinamarca para las maternas de alto riesgo las cuales son abordadas en sus casas y a través de las IPS para que sean atendidas también de manera oportuna.

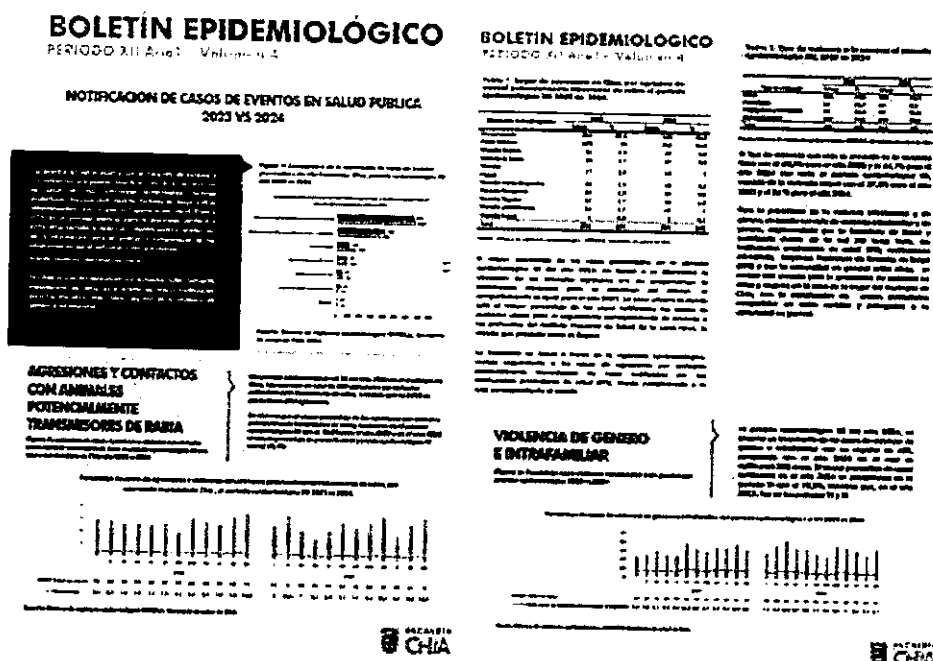
La sífilis gestacional y congénita tuvo 6.66 casos de sífilis gestacional, la mayoría de ellos también en población migrante y de esta manera también tenemos establecida una estrategia frente a este indicador de salud pública desde la Secretaría de Salud. Los defectos congénitos se notificaron 54 casos notificados muchos de ellos también con respecto a poblaciones que han venido trabajando en los diferentes sectores floricultores del municipio de Chía precisamente por esto se está haciendo una estrategia importante con las ARL que tienen en su mayoría son y ya se identificó son Positiva y Sura precisamente para disminuir la prevalencia de defectos congénitos que se tienen presentes en el municipio de Chía.

Consideramos que para traer el día de hoy estas estadísticas de salud pública estos son los indicadores que según notificación obligatoria son los que nos demarcan la gestión epidemiológica que hemos venido desarrollando en nuestro municipio, de igual manera también se le hizo conocimiento a la comunidad durante el mes de diciembre y enero del boletín epidemiológico que estuvo a lo largo de todas las redes sociales para que la comunidad también de igual manera entendiera y conociera cuáles eran por ejemplo las agresiones por contacto con animales potencialmente transmisores de rabia y esto no solamente tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas y estrategias de vacunación antirrábica en caninos y felinos sino precisamente es importante decirle a los ciudadanos y a los Honorables Concejales que en cuanto a casos de rabia tenemos cero en el municipio de Chía, al igual que embarazos de adolescentes precisamente por todas las estrategias que hemos tenido en los diferentes planteles educativos y no solamente ente públicos sino también privados a través de los enfermeros jefes y el equipo de la Secretaría de Salud.



Es importante también mencionar que la tasa también de incidencia en el consumo de sustancias psicoactivas se ha disminuido en un 25% precisamente por las intervenciones que hemos hecho hogar por hogar con todo el equipo encargado de eh la prevención de sustancias psicoactivas no solamente todas las sustancias psicoactivas como son la marihuana, la cocaína y demás sino también el tabaquismo y el alcoholismo precisamente porque identificamos que el abandono parenteral es lo que ha llevado a todo el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Chía, por eso luego entonces terminan en intentos de suicidio, gestos suicidios y violencias intrafamiliares que también ya las vamos a identificar durante esta presentación.

Este es el boletín epidemiológico que fue también de igual manera enviado no solamente a los Honorables Concejales sino a toda la comunidad del municipio de Chía.



Ahora bien, vamos a hacer una reseña importante con respecto a otro tema que se nos preguntaba en el cuestionario que hacía parte de 8 preguntas y tiene que ver con el SEM es decir, el Sistema de Emergencias Médicas en el municipio de Chía se estableció un convenio interdisciplinario en el año 2019 y Chía identificó que el Consejo de Estado había declarado de manera permanente que los convenios interdisciplinarios no interadministrativos no podían prorrogarse automáticamente y eso ocurrió con este convenio interadministrativo en el año 2021 era un convenio que tenía vigencia hasta el 2024 y se prorrogó automáticamente en contradicción de la jurisprudencia y de todo lo que ha declarado el Consejo de Estado con respecto a los convenios interadministrativos, esto el equipo de abogados de la Secretaría de Salud lo identificó enseguida lo pusimos en conocimiento de la Gobernación de Cundinamarca y es decir que veníamos contratando un personal con un convenio interadministrativo que ya no estaba vigente, por esta razón entonces la Gobernación de Cundinamarca se manifestó y determinó que se debía liquidar este convenio del sistema de emergencias médicas y hacer un nuevo convenio en lo cual la Superintendencia Nacional de Salud estuvo de acuerdo y de esta manera estamos en este momento prontos a firmar un nuevo convenio interadministrativo para el sistema de emergencias médicas.

Pero no hay que alertar a la comunidad diciéndole que no hay sistema de referencia y contrarreferencia en el municipio de Chía porque a pesar de que nosotros como municipio de Chía hacíamos parte del sistema emergencias médicas recordemos que a cargo de la Secretaría de Salud también está el sistema de emergencias



médicas del 123 que opera de manera articulada con las diferentes EPS y de igual manera con la presencia de bomberos en el 123 de nuestro municipio y también es importante que sepamos que a pesar de haber tenido un convenio durante tantos años solamente en 4 años se recibieron 2 casos del municipio de Chía que no se encontraban en ese momento que siendo residentes del municipio de Chía se encontraban en ese momento en Chía sino que marcaron al CRUE porque se encontraban en Bogotá y les contestaron del CRUE del departamento, porque nosotros en el municipio estamos geo cercados y todo este proceso del sistema de emergencias médicas y del sistema de referencia actúa directamente a través de las EPS a través del 123 que estamos fortaleciendo actualmente.

Ahora bien teníamos otras preguntas importantes con todos los indicadores de las cuales vamos a hablar y tiene que ver con las sanciones sanitarias, las medidas de seguridad sanitaria y sanciones sanitarias que ha venido implementando la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Vigilancia y Control el número de medidas sanitaria de seguridad sanitaria impuestas en el 2024 obedecen a 45 para el sector de alimentos, establecimientos cárnicos 27 y establecimientos de comercio 8 para un total de 80 medidas de seguridad sanitaria esto también con respecto a todas las actividades y operativos que se vienen realizando en los diferentes establecimientos y estas sanciones sanitarias generaron unas multas sanitarias por CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$5.253.333) es como digamos utilidad de las multas sanitarias de 107 procesos que se encuentran activos en este momento en la Secretaría de Salud.

Honorable Concejal le voy a dar el uso de la palabra si usted lo estima conveniente a la Directora de la Dirección de Vigilancia y Control la doctora Laura Martínez.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Disculpe doctora Laura hace parte de la planta.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Si señor es la Directora de Vigilancia.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Importante que se presente también para que quede el registro, muchas gracias.

SEÑORA LAURA XIMENA MARTÍNEZ ARTURO, DIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL

Buenas noches Honorables Concejales, mi nombre es Laura Martínez Directora de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud, con respecto, además de la aplicación de medidas sanitarias existen otros trabajos que son los operativos y en este caso los operativos relacionados con la lucha contra la clandestinidad y la legalidad en el sector cárnico, entonces la Secretaria de Salud pertenece al Comité Departamental de Carnes de Cundinamarca que es el comité que se reglamenta a través de la Resolución 3753 de 2013, esta instancia departamental define dentro de su jurisdicción cuáles son las principales problemáticas que existen y a partir de eso implementa estrategias para luchar contra esas.



En el caso de Cundinamarca es la lucha contra la ilegalidad y la clandestinidad en la carne y por lo tanto la Secretaría de Salud Municipal debe acompañar estas estrategias, entonces existe la circular externa conjunta que emitió el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario donde estableció qué competencias tenía cada dependencia y la nuestra es la del acompañamiento a los operativos interinstitucionales para la lucha contra la ilegalidad y la clandestinidad, entonces si bien es competencia de la policía implementar acciones contra el sacrificio clandestino, la Secretaría de Salud hace el acompañamiento para detectar este tipo de establecimientos o de lugares donde se está realizando y la policía nacional hace la incautación, esto aparte de las medidas sanitarias que nosotros hacemos en los establecimientos que sí son objeto de inspección vigilancia y control, entonces la Secretaría de Salud hace medidas sanitarias en los establecimientos abiertos al público y acompaña o puede acompañar en los operativos contra la ilegalidad y en los operativos que hacen contra vendedores informales o para la vigilancia de vendedores informales.

El problema del sacrificio ilegal son dos uno es la lucha contra el Abigeato en Cundinamarca que en Chía no sucede con frecuencia pero sí en el departamento en otros lugares y cuando un animal es sometido a sacrificio es inspeccionado recibe una inspección anti mortem y post mortem para detectar alteraciones anatómicas que tienen estos órganos y que deben ser decomisados para que no lleguen al consumo humano, entonces encontramos por ejemplo presencia de fasciola hepática, presencia de cisticercosis, de tuberculosis y estos órganos deben ser decomisados, cuando se hace sacrificio ilegal estos órganos no se decomisan sino que o se les corta el pedacito que se ve raro o se les modifica su apariencia para poder ser vendido y consumido.

Entonces la Secretaría de Salud en el 2024 hizo coordinaciones de acciones operativas y el acompañamiento operativos que debían ser liderados por Policía Nacional o Policía de Carabineros y Protección Ambiental entonces este es un caso del 19 de febrero donde se hizo la denuncia de un establecimiento ilegal con sacrificio ilegal y se logró la incautación de 187 kg de carne por parte de la Policía Nacional y el cierre de ese establecimiento que no cumplía, luego el 21 de febrero se encontró un vehículo particular que transportaba 194 gallinas y se logró hacer la coordinación con la Secretaría de Movilidad y con Policía Nacional y se logró la imposición del comparendo al vehículo, la imposición del comparendo por parte de Policía Nacional también y la incautación de 580 kg de pollo que evitó que llegaran al consumo de los habitantes del municipio.

Para este año el 12 de enero se encontró la venta ahí cerca de la plaza de mercado de 11 gallinas que era digamos ilegal y además estaban aparentemente se encontraban con color que también es una adulteración del alimento y son 44 kg que se lograron incautar y finalmente el 18 de enero de 2025 se logró incautar también un sacrificio ilegal de cerdo en la vereda Fagua para una marranada en una cancha de tejo y se logró la incautación de 68 kg de carne de cerdo por parte de policía evitando que esos alimentos lleguen al consumo de los habitantes del municipio.

Estas son las actividades de inspección vigilancia y control que se hicieron en 2024:

Fueron un total de 5.179 establecimientos sobrepasando la meta de los 5.000 establecimientos que se habían acordado en el Plan de Desarrollo:



Alimentos		Comercio		Alimentos		Comercio	
Tipo	Riesgo			Tipo	Riesgo		
Alimentos	Alto	2224	44,2	Alimentos	Alto	178	3,56
Comercio	Alto	206	4	Comercio	Alto	9	0,18
	Medio	455	9		Medio	24	0,48
	bajo	2294	45,6		Bajo	120	2,4
TOTAL		5179	103	Total		332	6,64

Con respecto a los vendedores informales de acuerdo al comunicado del INVIMA el INVIMA nos informa digamos recalca que los vendedores informales no son objeto de vigilancia y control a menos que sean ventas de alimentos en la vía pública de tipo formal reorganizadas o reubicadas por las autoridades competentes y autorizadas por estas conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional y las disposiciones de los gobiernos municipales, entonces es necesario que el encargado del espacio público determine un espacio adecuado que cumpla con las condiciones sanitarias y que autorice la permanencia de los vendedores informales en este espacio para que nosotros podamos hacer inspección, vigilancia y control de acuerdo a la Resolución 604 de 1993.

En este momento en el municipio no existe ese espacio y por lo tanto no son objeto de inspección, vigilancia y control, sin embargo, sí se ha hecho educación sanitaria porque se sabe que existen en el municipio y que de todas formas aún están digamos vendiendo el producto a los habitantes del municipio y por lo tanto se logró capacitar a 100 vendedores informales en las prácticas adecuadas de manipulación de alimentos logrando hacer mitigación del riesgo en el caso de estos vendedores informales.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Honorable Concejal ¿puedo continuar?

Lo ha dicho la doctora Laura, es importante tener en cuenta que nosotros con la compañía de la Policía Nacional haciendo obviamente caso a la 1801 hacemos incautaciones es solamente a productos cárnicos porque hacemos parte del comité departamental de cárnicos, a través del acompañamiento a la policía nacional y estos kilos que ya se definieron en la presentación de la doctora Laura estos kilos incautados lo que se hace es hacer la disposición de todos esos residuos a través de un contrato que se tiene para la disposición final de los residuos que se incautan a través de la Policía Nacional.

Con respecto a otra pregunta importante que hacía relación a las IPS que han sido visitadas tengamos en cuenta que nosotros solamente emitimos el concepto sanitario de las IPS de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Salud de Cundinamarca y encontramos 132 IPS con concepto favorables, 55 favorables con requerimiento que se les hicieron los seguimientos correspondientes para y un desfavorable que fue un consultorio odontológico ubicado en la milla de oro del municipio de Chía y este consultorio se le dio traslado a la Secretaría de Salud de Cundinamarca quien es el ente competente para realizar el cierre correspondiente de este consultorio odontológico para un total de 188 IPS intervenidas a través de inspección, vigilancia y control.

La educación sanitaria con un enfoque preventivo y un enfoque de riesgos tiene que ver con la promoción de la salud y precisamente estamos haciendo en estos cinco mil y algo de establecimientos que han sido visitados, toda la educación sanitaria para evitar las setas y todas las enfermedades de transmisión alimentaria que se puedan llegar a presentar y de esta manera prevenirlas en el municipio de

Chía haciendo muchas estrategias de información y educación, ¿cuáles han sido los resultados visibles de todas estas acciones de vigilancia y control? aquí trajimos varios establecimientos comerciales que fueron impactados por la Secretaría de Salud y vemos como antes se tenía una condición sanitaria y locativa muy diferente a cuando intervenimos con educación, con seguimiento y con acompañamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud en este establecimiento que obedecía a una panadería.

De igual manera también un restaurante ubicado en el sector de Bochica miremos cómo entendieron que las buenas prácticas de manipulación de alimentos van más allá de la intención sino que también debían hacer inversiones en infraestructura importantes, este es el antes y el después de los establecimientos que han venido siendo intervenidos por la Secretaría de Salud.

ANTES



DESPUES



Es así entonces que la certificación sanitaria, esto tiene que ver con la calidad de agua la vigilancia de calidad del agua también del agua potable en el municipio de Chía también hace parte de las funciones que tiene a su cargo la Secretaría de Salud, la certificación sanitaria municipal durante todo el año 2024 fue con un concepto favorable y un índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano municipal sin riesgo durante el año 2024 qué estrategias llevamos a cabo precisamente en compañía no solamente de EMSERCHÍA sino a través de las visitas sanitarias de los operadores como Progresar y Tibitoc en sus diferentes puntos y cuando identificamos solamente un punto que fue en el taller artesanal un riesgo medio se informó a EMSERCHÍA para que tomaran medidas correspondientes y de esta manera se hiciera la intervención, el lavado del tanque que tenemos ubicado en Fonquetá y de igual manera también la medición del PH y del cloro en este sector para llegar a un nivel sin riesgo para todo el municipio de Chía, es una preocupación grande que tiene nuestra comunidad frente a la potabilización del agua o no y en esto la doctora Laura les va también ampliar la información.

SEÑORA LAURA XIMENA MARTÍNEZ ARTURO, DIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL

Como conclusión para el año 2024 a través de todas las mediciones que hace en los diferentes puntos de muestreo del municipio se carga en la plataforma SIVICAP y al final del año se logra emitir de acuerdo de acuerdo con los muestreos realizados 94 tomas de muestras de agua potable en los puntos concertados sobre la red de los prestadores del servicio, estos puntos están ubicados en todo el municipio, incluidas las veredas. Se obtiene el concepto favorable para el municipio de Chía con un IRCA sin riesgo, es decir, que la calidad del agua en el municipio es buena, excelente y no representa un riesgo para la salud pública.



Además de esas 94 muestras, se realizaron 28 tomas adicionales para medir cloro y pH en puntos de la red de distribución, y se obtuvo el certificado favorable para los dos prestadores que existen en el municipio: EMSERCHÍA y Progresar.

Finalmente, se realizaron cuatro puntos de muestreo adicionales, incluidos en EMSERCHÍA, Progresar y dos prestadores privados que tienen sus propios sistemas de distribución de agua potable, como el Colegio Calasanz e IMG. Se les hace monitoreo y se les entrega el reporte correspondiente para que realicen los correctivos necesarios, en caso de requerirse.

Para 2025, este es el resultado del muestreo: en la muestra del 30 de enero de 2025 se emitió un oficio, de acuerdo con el Cuadro 7 de la Resolución, para notificar a la persona prestadora, al COVE municipal y a todos los relacionados con el tema, con el fin de implementar los correctivos y volver a muestrear el punto. Esta verificación se realizó en el Taller Artesanal.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Capítulo: Enfermedades zoonóticas

Se abordan enfermedades como rabia, geohelmintiasis, toxoplasmosis, leptospirosis, tuberculosis y brucelosis. Cabe anotar que enfermedades como la fiebre amarilla y el Chagas no corresponden a enfermedades zoonóticas, ya que no son transmitidas por un animal vertebrado, sino por invertebrados. Por lo tanto, son enfermedades transmitidas por vectores.

Las estrategias implementadas para el control de enfermedades zoonóticas, particularmente la rabia, incluyen:

Vacunación antirrábica: se vacunaron 15.491 animales, de los cuales 10.309 fueron perros y 5.840 gatos, para un total de 20.696 animales vacunados. Cabe recordar que en Chía también hay IPS privadas que realizan vacunación, por lo que se les hace seguimiento.

La cobertura de vacunación en 2024 fue del 93,7%, superando ampliamente la meta establecida por la Gobernación de Cundinamarca, que era del 80%.

Se reportaron 573 accidentes por animales agresores, de los cuales 454 correspondieron a caninos y 118 a felinos.

La vigilancia activa de rabia arrojó resultados negativos en el municipio, por lo que se reportan cero casos de rabia humana y animal en Chía durante el periodo.

Toxoplasmosis

Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres gestantes. Se realizó una campaña informativa, ya que el gato no es el transmisor directo, sino que la principal fuente son carnes crudas o alimentos contaminados.

Se benefició una población de 69 mujeres gestantes.

No se presentaron notificaciones de toxoplasmosis en el municipio en 2024, es decir, cero eventos notificados.

SEÑORA LAURA XIMENA MARTÍNEZ ARTURO, DIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL

En el año 2024, se implementaron charlas de prevención para mujeres gestantes, teniendo en cuenta el riesgo de toxoplasmosis congénita. La enfermedad puede estar presente en un tercio de la población, aunque en personas inmunocompetentes suele ser asintomática. En cambio, puede tener efectos en personas inmunosuprimidas o en fetos.

Y se informa a la comunidad que, si bien el gato tiene capacidad de transmisión, esta se da principalmente en gatos cachorros. La principal fuente de contagio son las carnes crudas o los alimentos contaminados, como vegetales sin desinfectar. Eso es lo que se les está enseñando a las mujeres gestantes en el municipio de Chía.

Leptospirosis

La prevención se enfoca principalmente en las charlas de tenencia responsable, la vigilancia de factores de riesgo por presencia de roedores y el control de roedores que realiza la Secretaría de Salud en: Vías públicas, Edificios públicos y Espacios públicos del municipio.

Las acciones también incluyen control de vectores para enfermedades como: Chagas, Dengue, Fiebre amarilla y Zika. Se han implementado visitas diagnósticas e intervenciones institucionales como parte del control y seguimiento de estas enfermedades.

En el municipio se han implementado medidas para que los habitantes que viajen a zonas endémicas y de riesgo tomen precauciones, conozcan los síntomas de las enfermedades y puedan acudir a atención médica oportuna. En el caso específico de la fiebre amarilla, se promueve el acceso a la vacunación.

Estos son ejemplos de los factores de riesgo encontrados en el municipio que claramente favorecen la presencia de plagas y que han sido intervenidos. En caso de que no se corrijan, se remiten a la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos para que, mediante la Ley 1801, se realice la intervención correspondiente por parte de la inspección de policía.

Entre otros ejemplos, hemos encontrado restaurantes que sacan sus basuras en condiciones inadecuadas, acumulación de inservibles, y falta de poda. Algo muy importante que queremos destacar es que el Ministerio de Salud ha sido claro en advertir que la prevención de plagas no se logra mediante el uso de productos químicos, ni en Chía ni en ninguna parte de Colombia. La prevención se basa en el manejo integral de plagas, lo cual incluye la reducción de factores de riesgo y la educación sanitaria. Solo cuando se han corregido estos factores y aún se evidencian plagas, se procede a realizar intervenciones químicas.

El control de roedores en los objetos de inspección, vigilancia y control también es fundamental. Es importante aclarar que las medidas sanitarias no tienen como fin impedir que los establecimientos comerciales operen o pierdan su sustento económico. Sin embargo, cuando se detectan factores de riesgo que representan una amenaza para la salud pública, se hace necesaria su intervención. Las medidas sanitarias se aplican únicamente al evidenciarse la presencia de plagas, y se levantan una vez se han corregido los factores de riesgo y se ha realizado la intervención respectiva.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Prevención de Geohelmintiasis

Recordemos que “geo” significa tierra y “helminos” son gusanos, es decir, los gusanos que se encuentran en la tierra, muchas veces por la presencia de materia fecal canina y felina en espacios públicos. Esta problemática se ha identificado sobre todo en los parques del municipio de Chía.

Como medida de prevención, la Secretaría de Salud realizó un plan piloto en 2024, ubicando canecas especiales en parques como: Parque Guaya, Parque de las Flores, Parque Ocaviga y Las Acacias. Estas canecas permiten la recolección adecuada de excretas, contribuyendo a prevenir esta enfermedad. Se estima que hasta un 29,62% de la población escolar podría estar afectada por geohelmintiasis si no se toman medidas.

La Secretaría de Salud inició este plan con una campaña de sensibilización sobre la recolección de materia fecal. Es importante aclarar que la Secretaría no es la encargada de recoger las heces, sino que esta es una campaña de tipo preventivo enfocada en parques públicos con alta afluencia de animales y personas.

Durante el año 2024, se recolectaron 12.039 kg de excretas en los 11 contenedores instalados. Estas fueron sometidas a un proceso de biotransformación, del cual se obtuvo un total de 2.910 kg de abono orgánico libre de patógenos, entregado a la Secretaría de Desarrollo Económico para su uso en proyectos productivos agropecuarios.

La geohelmintiasis también se previene mediante campañas de desparasitación, que se realizaron durante las jornadas de vacunación antirrábica. En 2024, se desparasitaron: 2.518 caninos y 1.344 felinos. Además, se llevaron a cabo 354 charlas de tenencia responsable de mascotas, principalmente en propiedad horizontal, promoviendo la participación activa de la comunidad en estas estrategias de información y prevención lideradas por la Secretaría de Salud.

Las Esterilizaciones durante 2024, se realizaron un total de 14.458 cirugías de esterilización, distribuidas de la siguiente manera: 5.148 caninos y 9.720 felinos. Esta intervención representó una inversión de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$144.900.000). Se garantizó la desconcentración del servicio, llegando no solo al casco urbano, sino también a todas las veredas del municipio, ampliando así la cobertura y el impacto de estas acciones.

¿Cómo se identifican estos caninos? No son únicamente perros callejeros. Para ello, se implementa la estrategia CES, que corresponde a Capturar, Esterilizar y Soltar a los caninos sin propietarios. Estos caninos y felinos están incluidos en las estadísticas generales, pero es importante tener en cuenta que estas esterilizaciones se brindan a toda la población del municipio de Chía, sin importar la estratificación del tenedor.

Desde la Secretaría de Salud también estamos implementando una campaña de educación relacionada con las palomas. Estas han sido catalogadas como especie domesticada y exótica, por lo tanto, no se consideran plaga. La manera en que podemos impactar esta situación es educando a la comunidad del municipio para que no les brinde alimentación.

Una paloma en cautiverio, bien cuidada, conservada y alimentada, puede tener una esperanza de vida de 15 años o más, mientras que una paloma que vive en ambientes silvestres, sin acceso regular a alimentos, suele vivir entre 5 y 7 años. Por esta razón, hemos venido evidenciando casos en el casco urbano, como un Fruver donde las palomas se alimentaban, por ejemplo, de alverja.



Estas campañas de educación y sensibilización son lideradas por la Secretaría de Salud. Esta información se comparte también en la Junta Defensora de Animales, donde ningún Concejal realizó preguntas al respecto.

Salud Mental

Es importante informar tanto a los Concejales como a la comunidad del municipio que, a través de la estrategia del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), que incluye a los gatekeepers y las brigadas de salud, se atendieron 526 personas durante el año 2024. En lo que va corrido del año 2025, se han intervenido 30 personas con los Centros de Escucha, que están ubicados en tres puntos de atención: Casa de la Mujer, Salón Comunal Nuestra Señora del Rosario y Mercedes de Calahorra, adicionalmente, se ha implementado un nuevo centro en la Villa Olímpica. Hasta el momento, se han atendido 411 personas, mediante un modelo de atención que incluye tres sesiones por usuario, como parte del programa “Charlemos”.

La unidad móvil de zoonosis, que ustedes han visto operando, ya no puede manejar medicamentos de control, según lo dispuesto por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Por ello, esta infraestructura será acondicionada por el Alcalde para convertirse en un Centro Charlemos Móvil, que recorrerá todo el territorio municipal. Así, se complementarán los centros fijos con atención móvil.

También continúa operativa la línea de teleorientación en salud mental, que permite abordar a personas con diversas problemáticas. En los casos más severos, se realiza la remisión a las EPS, para la intervención profesional por parte de psicólogos o psiquiatras de la red prestadora de servicios de salud.

Zonas de Orientación Escolar (SOEC)

Se han atendido 536 personas en diferentes instituciones educativas, como el CONALDI, Diosa Chía y La Balsa. Como resultado de esta estrategia, los intentos de suicidio en la comunidad educativa se redujeron en un 45% y no se presentó ningún caso de suicidio en los planteles educativos oficiales.

Cabe aclarar que los nueve suicidios registrados en el año 2024 correspondieron a personas mayores de edad, no estudiantes. Esto demuestra que la estrategia está dando resultados positivos, por lo que se continuará ampliando su cobertura en las instituciones educativas municipales.

También se han formado equipos psicosociales y se ha capacitado en primeros auxilios psicológicos tanto a la comunidad educativa como a líderes comunitarios, como Presidentes de Juntas de Acción Comunal, para que puedan brindar una primera atención en salud mental a personas que presenten síntomas de depresión, ansiedad u otros trastornos.

Hoy en día, la salud mental se ha convertido en una problemática global, y en nuestro municipio la estamos interviniendo activamente. Como dice uno de los psicólogos del PIC de la Secretaría de Salud: “Caras vemos, pero salud mental no conocemos.” Esto refleja la necesidad de conocer y entender con quién nos relacionamos, para evitar situaciones que puedan desencadenar en intentos o actos suicidas.

Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas

Se llevó a cabo la Semana de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, una estrategia que ha demostrado buenos resultados para el municipio de Chía. Hemos reducido en un 42% la adicción en el municipio de Chía, precisamente





gracias a todas las estrategias implementadas. Abordamos a 871 personas pertenecientes al grupo poblacional de instituciones educativas oficiales. De igual manera, se llevaron a cabo intervenciones en el SENA.

El Foro Charlemos, en el que participaron varias personas y tres expertos en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, continuó realizando gestión, educación e intervención, abordando este tema tan importante y sensible en el municipio, con 150 personas beneficiadas.

La Carrera de Prevención del Suicidio también se realizó en diferentes colegios, tanto públicos como privados del municipio de Chía. Esta iniciativa surgió al identificar, durante el año 2023, que la ideación suicida se estaba focalizando en las instituciones educativas oficiales. Por eso, se implementaron diversas estrategias, cuyos resultados positivos ya hemos mencionado.

La Línea de Salud Mental Escucha abordó, hasta diciembre, a 12 personas, quienes recibieron atención con resultados favorables. A ocho de ellas se les hizo seguimiento psicológico, y cuatro debieron ser remitidas a IPS hospitalarias con el apoyo de las ambulancias de bomberos y la presencia de la Policía Nacional, debido a diagnósticos como esquizofrenia y otros trastornos mentales, que requerían atención psiquiátrica y farmacológica para estabilizar su salud.

Con respecto a discapacidad, como lo preguntaba el Concejal Felipe Galvis, es importante mencionar que durante el año 2024 se expidieron 573 certificados de discapacidad. Los beneficios para esta población se otorgan a través de un convenio con el Hospital San Antonio de Chía, en donde un equipo interdisciplinario evalúa a los usuarios con el fin de restablecer sus derechos jurídicos y legales, relacionados con sucesiones, pensiones por invalidez y otros trámites.

Cabe recordar que ya no existe la figura de interdicción como en el pasado; actualmente, el certificado de discapacidad es el documento oficial para estos procesos, incluso cuando la discapacidad fue adquirida en el entorno laboral.

Esta población cuenta con prioridad en la atención médica y especializada, así como en la gestión de medicamentos a través de los actores del sistema de seguridad social en salud. Sin embargo, aún no existen programas municipales relacionados con transporte público para personas con discapacidad, como sí ocurre en ciudades como Bogotá, donde el certificado permite el acceso a beneficios en sistemas como el Transmilenio.

Incluso siendo residentes de Chía o Cundinamarca, estas personas aún no cuentan con ese tipo de cobertura.

Creemos que hemos hecho una presentación bastante amplia con respecto a las preguntas planteadas inicialmente en el cuestionario que acompañaba la Proposición 008, así como a las preguntas adicionales que no estaban incluidas, pero que han sido remitidas a nuestro despacho en la Secretaría de Salud.

Estas serán respondidas de manera oportuna, como es nuestro compromiso permanente por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud.

Muchas gracias, señor Presidente. Damos por terminada la presentación y la respuesta a la mayoría de las preguntas formuladas por ustedes.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias, doctora Luz Estela.





Voy a dar el uso de la palabra a la comunidad. Hay una persona inscrita, que desea intervenir.

Pregunto a las personas que se encuentran en las barras de la comunidad:
¿Alguien más desea participar?

En ese caso, antes de dar el uso de la palabra, por favor declaramos la sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Y, de una vez llamamos a lista para constituírnos en sesión permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la declaración de la sesión permanente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos en sesión permanente.

Ahora sí, señor Luis, puede hacer su intervención. Recordamos que tiene un tiempo máximo de cinco minutos.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para todos. Saludo a la mesa directiva del Concejo, a los Honorables Concejales y Concejalas, a la mesa directiva de la Secretaría de Salud, a las barras y a las redes sociales.

Hoy quiero felicitar a todos los Concejales porque hicieron un verdadero control político. Igualmente, felicito a la doctora Luz Estela Díaz y a su equipo por el gran trabajo y la exposición de todos los temas que les correspondía cubrir.

Solo me resta exponer dos situaciones que me han ocurrido aquí en el municipio en los últimos seis meses.

La primera, desafortunadamente, fue con un can. Me fracturé la muñeca hace seis meses. Cuando fui a abordar a la señora dueña del perro, muy decente ella, entendió la situación. La operación me costó CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$400.000). Afortunadamente, gracias al Altísimo, tengo los recursos y no le puse problema, porque la señora fue consciente.

El segundo caso me ocurrió el Jueves Santo. Un perrito me rebasó y casi me hace atropellar por un carro en la calle 12, cerca del Sazón de la Abuela. Le dije a la niña que lo llevaba: "Hágame un favor, amarre a ese perro." Ella respondió: "Ya voy a llamar a mi papá." Cuando salió el papá, perdónenme la expresión, pero es como fue, salió con una cara bastante hostil y me dijo: "El que se mete con mi perro, se mete conmigo." Le respondí: "Señor, los inconvenientes se resuelven en paz. Ya llamé a las autoridades." Él me dijo: "¿Ah, me va a emproblemar con las autoridades?" Le contesté: "Mírelos, ahí vienen. Ya viene Seguridad Fénix y también la patrulla, esto hay que definirlo claramente."

Casi me atropella un carro, bendito sea Dios que el conductor tuvo la pericia de esquivarme. La policía llegó, analizó la situación y le explicó al señor que, si no contenía al perro, este sería capturado por las autoridades y él tendría que pagar una multa. Finalmente, se solucionó el impase. Ahí les dejo la inquietud. Ustedes saben que yo soy breve. Porque como pasa en la iglesia: si un cura se extiende, me aburre. Pero si es directo, como yo, ¡me encanta el sermón!

El señor Presidente del Concejo sabe que todos los días llego a mi trabajo a las 7:00 a.m. ¿Por qué? Porque mi trabajo empieza cuando inicia la Eucaristía. ¿Y por quién estoy orientado? Ustedes me preguntarán. Pues por este Señor, los 365 días del año.

No es más, señor Presidente. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por la intervención. Continuamos con la intervención del señor Carlos Villota.

SEÑOR CARLOS VILLOTA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD.

Muy buenas noches a todos. Buenas noches a la mesa directiva. Es la primera vez que estoy en el Concejo de Chía como ciudadano, periodista y también para dar un testimonio de vida.

No sé si ustedes se han enterado, pero el pasado martes de Semana Santa tuve un problema de salud bastante serio, justo en el parque principal de Chía, alrededor de las 8:15 p.m. Salía de hacer un programa en vivo de En Primer Plano Sabana Centro, de la emisora Luna Estéreo. Ese día, habíamos tocado un tema que nos conmovió: la tragedia en la discoteca "Jet Set" de Santo Domingo. En exclusiva presentamos dos testimonios.

Estaba tranquilo, conmovido, y mientras pasaba por el parque recibí una llamada del departamento de comunicaciones del gobierno dominicano para felicitarme por el programa. Justo en ese momento, sentí un dolor fuerte en el pecho. Me tomé el pecho, y creo que perdí la conciencia por unos 10 o 15 segundos.

No quiero victimizarme. Quiero destacar esta historia no por mí, sino por ustedes, el Concejo, y por el sistema de salud de Chía.

Quiero destacar lo siguiente, doctora, señora Secretaria de Salud (muy buenas noches): Ese día pasaba por ahí el Concejal Pablo Andrés Castro, quien tomó una decisión de liderazgo, de trabajo en equipo. Me reconoció. Pero más allá de ser periodista, soy un ciudadano común y corriente. Amo a Chía. Aquí vive mi hija, mis nietos, y quiero quedarme aquí.

El aplauso es para el sistema de salud de Chía, porque si el Concejal Pablo Andrés Castro no hubiera pasado en ese instante, probablemente no estaría aquí. Así me lo dijo el médico.

El Concejal llamó a la ambulancia y a la Secretaría de Salud. No lo hizo a título personal, sino como representante del Concejo. Cuando llegó la ambulancia, la señorita que me atendió me dijo: "Usted está que se va. Tiene 170 de presión. Vamos al hospital."

Cuando llegué, ya me estaban esperando gracias a la gestión previa del Concejal. Había alrededor de 150 personas en urgencias, pero me dieron prioridad. El médico que me atendió costeño, a quien saludo aunque no recuerdo el nombre me dijo: "Si usted hubiera llegado 3 o 4 minutos más tarde, no estaría aquí."

Por eso, quiero dar testimonio del sistema de salud de Chía, por su prontitud y su humanidad. También quiero dejar una reflexión: ¿qué habría pasado si nadie hubiera pasado por allí? ¿Qué hubiera ocurrido si me quedaba tirado en ese parque?

Al día siguiente tuve la fortaleza y salud para entrevistar al Concejal Castro. No sé si lo vieron, pero el testimonio se viralizó: salió en medios de Argentina, Perú y otras partes. De ese reportaje de En Primer Plano Sabana Centro, historias de vida que son positivas no solamente para Chía, sino también para ustedes como Concejales. Creo que ustedes son la representación de la ciudadanía, y el Concejal Pablo Andrés Castro hizo quedar bien al Concejo, más allá de cualquier cosa relacionada con partidos políticos.

Esta es una ciudad hermosa. Ustedes tienen una gran responsabilidad, y yo también la tengo como director del programa En Primer Plano Sabana Centro, que me he dado a la tarea de proyectar a nivel local, regional, nacional e internacional.

Con toda la venia, y porque creo que esto no pasa muy seguido, propongo un aplauso para todos ustedes y un aplauso especial para el Concejal Pablo Andrés Castro, por esa acción que salvó mi vida y por su liderazgo.

Y finalmente, los invito a seguir trabajando. Esta es una labor silenciosa que ustedes hacen como Concejales, y la verdad, la gente se da cuenta. Se da cuenta de lo que hacen.

¡Dios los bendiga! Y en mí siempre tendrán un ciudadano responsable. Si alguna vez quieren contar conmigo en lo que hacemos desde el programa que tiene impacto a nivel de Colombia e Iberoamérica, con estadísticas que lo demuestran, siempre podrán contar conmigo.

¡Dios los bendiga y muchas gracias! Amén.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



A usted, don Carlos, gracias por su intervención y por su testimonio de vida. De verdad, nos da mucha alegría que lo hayan atendido de manera oportuna, sobre todo con ese tipo de episodios que sabemos que pueden ser fulminantes, donde un segundo de demora puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Felicitemos también al Concejal Pablo, porque, según lo manifestado por el ciudadano, si no hubiera sido por su ayuda, lamentablemente otra habría sido la historia.

Esa es la invitación: que sepan que los Concejales no solo estamos aquí para sesionar, ejercer control político o estudiar proyectos de acuerdo, sino también para estar cerca de la comunidad. Todos los Concejales estamos aquí representando una curul gracias a ustedes, los ciudadanos, que nos apoyaron en las urnas.

Muchas gracias por venir a participar en este espacio. Cosas como estas también es importante conocerlas. No todo puede ser malo; hay cosas que valen la pena resaltar, y es importante que la comunidad lo manifieste, especialmente en escenarios como este.

Declaramos la sesión formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, si alguno tiene alguna pregunta adicional o desea aclarar alguna respuesta dada por parte de la Administración municipal, este es el momento para hacer su intervención.

No hay intervenciones. Entonces, si no hay más intervenciones, doctora Luz Estela, ¿desea dar alguna respuesta adicional a la comunidad que participó?

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Gracias, Honorable Presidente del Concejo.

Efectivamente, lo sucedido demuestra que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está funcionando. Recibimos la llamada al 123 por parte del Concejal Pablo, y así fue como se abordó la ambulancia.

En este caso fue gracias al Concejal, pero normalmente, a través de las cámaras de seguridad y el 123, también identificamos este tipo de eventos y trasladamos una ambulancia según la operatividad del municipio de Chía.

Estamos haciendo monitoreo permanente en las horas nocturnas y directamente y durante el día lo hace nuestro equipo de enlaces de la Secretaría de Salud, con el fin de asegurar atención y acompañamiento a los pacientes.

Respecto al primer ciudadano que intervino, también se le brindó la atención debida, aunque no se trató de un caso rábico, sino de un accidente ocasionado por un animal bajo custodia de un tenedor irresponsable. Este caso evidencia la



atención oportuna y la vigilancia que hacemos frente a todas las emergencias médicas en Chía.

Seguiremos trabajando, porque aún hay mucho por hacer. También daremos respuesta a todas las preguntas que los Honorables Concejales radiquen en la Secretaría de Salud, de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente.

Muchas gracias, señor Presidente, Honorables Concejales y comunidad.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Solamente para hacerle a la doctora Luz Estela, una pregunta: ¿quién terminó lo del SEM? ¿Fue la Gobernación o el municipio? ¿Quién decidió retirarlo?

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

La decisión fue tomada por la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Salud Departamental, Concejal Montañez.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Yo tenía entendido que había sido el municipio.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

La situación jurídica fue identificada entre varios municipios. El error jurídico en el convenio se trasladó a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que forma parte del convenio tripartito interadministrativo entre Funza, Mosquera, Soacha, Chía y la Gobernación de Cundinamarca.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Eso quiere decir que actualmente, la respuesta a emergencias médicas se está haciendo a través de Gestión del Riesgo y Bomberos, ¿de quién depende Bomberos?

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

El CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) depende de la Gobernación de Cundinamarca. En este momento estamos articulados con el CRUE, que sigue en operación, mientras avanzamos en la etapa precontractual del nuevo convenio, con el que todos los municipios entregarán su talento humano al CRUE.

Entonces, estamos articuladamente con el CRUE de Cundinamarca, cuya operación está vigente. Estamos trabajando con todos los municipios, los cuatro municipios, y se adhirieron también dos municipios de segunda categoría. Están haciendo la intervención, las intervenciones, y de igual manera, de manera corresponsable, estamos también desde el 123 realizando toda esta atención del sistema de emergencias médicas en el municipio de Chía.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Es decir, esa falencia que hubo ya fue superada y se está gestionando un nuevo convenio. En este momento, el convenio del SEM queda nuevamente con el CRUE.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD

Señor Presidente, se me olvidó...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal, le pido una moción de orden. Esto se está volviendo un diálogo informal, y tenemos otro proyecto en el orden del día.

Entonces, no sé, doctora Angélica, si tiene todas las inquietudes para que las manifieste ante la plenaria, y así la doctora pueda contestar esas inquietudes de manera ordenada. Porque se vuelve un diálogo, y creo que, de acuerdo con los lineamientos como ya lo dijo un Concejal que ejerce el control político, y lo que mencioné al inicio de esta sesión, lo ideal es que podamos, de manera organizada, dar finalización a este punto, si a bien lo tienen los Concejales, para poder continuar con el siguiente punto del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

No, yo voy a radicar... perdón, Presidente, le pido el uso de la palabra. Como son varias preguntas, voy a radicar; solo quería saber si el SEM continúa, porque eso tiene un tema jurídico que es importante, y que el municipio continúe con él.

Simplemente era eso, y pedirles el favor esto sí lo dejo aquí de revisar el boletín epidemiológico, que tiene datos que no son los reales, que tiene la Secretaría, para que lo revisen, porque debió ser un error de digitación. Para que les quede bien el boletín epidemiológico. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal.

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?

Si no hay más intervenciones, doctora Luz Estela, tiene usted el uso de la palabra.

SEÑORA LUZ STELLA DÍAZ JALLER, SECRETARIA DE SALUD



Gracias, señor Presidente. Les doy un agradecimiento muy grande por este control político, y de igual manera les deseo una feliz noche, una buena continuación de esta sesión plenaria.

A toda la comunidad del municipio de Chía: estamos siempre atentos a servirles desde la Secretaría de Salud, y estaremos también atentos a todas las preguntas que nos alleguen. De igual forma, responderemos a los Honorables Concejales para que puedan ejercer su objetivo principal y función, que es el control político a la Administración municipal de Chía.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias, doctora Luz Estela, a sus directores, a los funcionarios y contratistas que la acompañaron en este control político, dando cumplimiento a la proposición No. 08 de 2025. Damos por finalizado el control político hacia la Secretaría de Salud. Pueden retirarse.

Siguiente punto del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

5. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: ***“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***.

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Funcionarios citados:

- Doctora Luz Aurora Espinoza Tobar, Jefe de la Oficina Jurídica.
- Doctora Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.
- Doctor Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, teniendo en cuenta que ya estamos en este quinto punto del orden del día, me parece importante hacer un análisis bien juicioso sobre la decisión que se va a tomar con este proyecto de acuerdo.

Teníamos presupuestado que, de pronto, este control político se iba a demorar más o podría extenderse por dos días, pero vemos que se pudo desarrollar en un solo día.

Entonces, sugiero si a bien lo tiene la plenaria apoyar esta iniciativa: Elevo a proposición el aplazamiento de este Proyecto de Acuerdo para el día de mañana, quedando como primer punto del orden del día.

Señorita Secretaria, por favor, tomemos votación para la aprobación o negación del aplazamiento del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO



NATALIA GIL LOAIZA
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por el aplazamiento de la continuación en el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición de aplazamiento.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

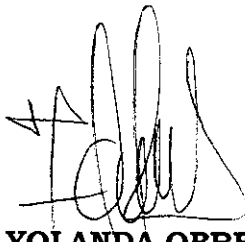
El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 9:02 p.m. del día 28 de abril de 2025, doy por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy y cito para mañana a partir de las 4:30 p.m.

Feliz noche, Honorables Concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.
Secretaria General (E)

Elaboró: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana María Paniagua Torres, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón, Eslendy Dayani Gualtero Castro, Secretarios.

Revisó: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana María Paniagua Torres, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón, Eslendy Dayani Gualtero Castro, Secretarios.
Yizza Yolanda Obregón Triviño, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará Actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.

